등록번호: 11255003
주민등록번호: 950209-219**** 여/30세
환자명: 박은비

# 외래초진기록

2025-03-14

진료과 신경과

주치의 권영남

주호소 및 기간

과거력

Hypertension ◉ No ○ Yes

Pul. Tbc ◉ No ○ Yes

DM ◉ No ○ Yes

Hepatitis ◉ No ○ Yes

Drug Allergy ◉ No ○ Yes ** Yes선택시 구체적인 항생제 계열도 선택해주세요.

☐ Penicillin ☐ Sulfonamide ☐ Cephalosporin

☐ Other

알레르기 ◉ No ○ Yes

Others

현재질병상태

---

2024.11 두통, 어지럼,
주로 우측 측두부 에서 앞뒤로, 콕콕 찌르는 양상.
N/V -/-
duration: 2-3days?
freq: continual → 현재는 많이 호전됨.
편두통 약 복용하고 많이 호전됨: 테그레톨 에어탈 데파스 리보트릴

2025.2 부터 시각인지저하..? 사람얼굴이 흐릿하게 보인다.
글씨가 안읽힌다? 글씨를 읽으면 힘들다. 눈이 조여오는 것 같다.
촛점이 안맞는다?
두개로 보이지는 않는다? 겹쳐보이는것도 아니고

다리에 힘이 안들어가서 주저앉을뻔했다. 한번.
팔에 힘이 빠져나가는 느낌이 있다. 저림은 아니다.
머리감고 드라이하는데 문제없다.

글씨쓰기 수저질은 잘한다.

안과검사에서는 이상 없다고 들음. 좌안 시력저하만.
양안 다 어두워보인다.

---

**신체검진**

General appearance ◉ normal ○ abnormal

Skin ◉ normal ○ abnormal

HEENT ◉ normal ○ abnormal

Neck ◉ normal ○ abnormal

Chest/lung ◉ normal ○ abnormal

Heart ◉ normal ○ abnormal

Abdomen ◉ normal ○ abnormal

Back and extremity ◉ normal ○ abnormal

# 외래초진기록

2025-03-14

| | |
|---|---|
| 신경학적 진찰소견 | CNE : L/R : 2mm/2mm isocoric, prompt<br>EOM : Full s nystagmus<br>blurred vision +++<br>Facial expression : symmetric, intact<br>Facial sense : symmetric, intact<br><br>Motor<br>upper: V/V<br>lower : V/V<br><br>Sensory<br>symm, intact to pain, temp, vibration, position<br><br>DTR<br>Biceps : ++/++<br>Knee : ++/++<br><br>Toe sign : flex/flex<br><br>Cerebellar Function Test<br>F to N : intact/intact<br><br>Gait : normal<br>Tandem gait : intact |
| 추정진단 | HA<br>r/o MG<<br>r/o IICP?<br>r/o functional |
| 계획 | brain MRI + orbit<br>VEP<br>RNST<br>AChR Ab<br>prn CSF study |
| 기록자명 | 권영남(의사) |

등록번호: 11255003
주민등록번호: 950209-219**** 여/30세
환자명: 박은비

# 영상검사 CT& MR

## 영상검사 CT& MR

| | | | |
|---|---|---|---|
| 검사명 | MRI Brain & Angio 3D(Neck포함)/diffusion(contrast) | | |
| 검사방법 | | | |
| 검사일자 | 2025.03.30 12:44 | 촬영실 | MRI 25호(암병원 2층) |
| 판독일자 | 2025.04.17 14:54 | | |
| Description | Clinical Information: Encephalopathy, unspecified<br>Imaging technique: sagittal T1WI, axial T1WI, T2WI, T2 FLAIR, T2*WI, contrast enhanced 3D T1WI with axial/coronal/sagittal reconstruction, intracranial TOF MRA, contrast enhanced intracranial and neck MRA, DWI.<br>Contrast media: Used<br><br>Steno-occlusion of bilateral terminal ICA, MCA, and ACA.<br>Stenosis, bilateral P2.<br>Prominent basal collateral formations.<br><br>Small tiny recent infarction at right internal borderzone.<br>Chronic infarction at right temporo-parieto-occipital lobe and right frontal WM.<br><br>No other significant ischemic lesion, hemorrhage, hydrocephalus, mass or atrophic change is noted in cerebral hemisphere, cerebellum, brainstem, ventricle and extra-axial space.<br>Otherwise, no significant stenosis, occlusive lesion or aneurysm in intracranial and extracranial major arteries.<br><br>Conclusion:<br>1. Suggestive of Moyamoya disease.<br>2. Small tiny recent infarction at right internal borderzone.<br>3. Chronic infarction at right temporo-parieto-occipital lobe and right frontal WM.<br><br>◈조영제◈<br>Gadovist prefilled inj[15ml/Syringe] [Gadobutrol 604.72mg/ml] [15 ml/Syringe]:1 | | |
| 판독의/전문의 | 서배선/서배선/서배선 | | |

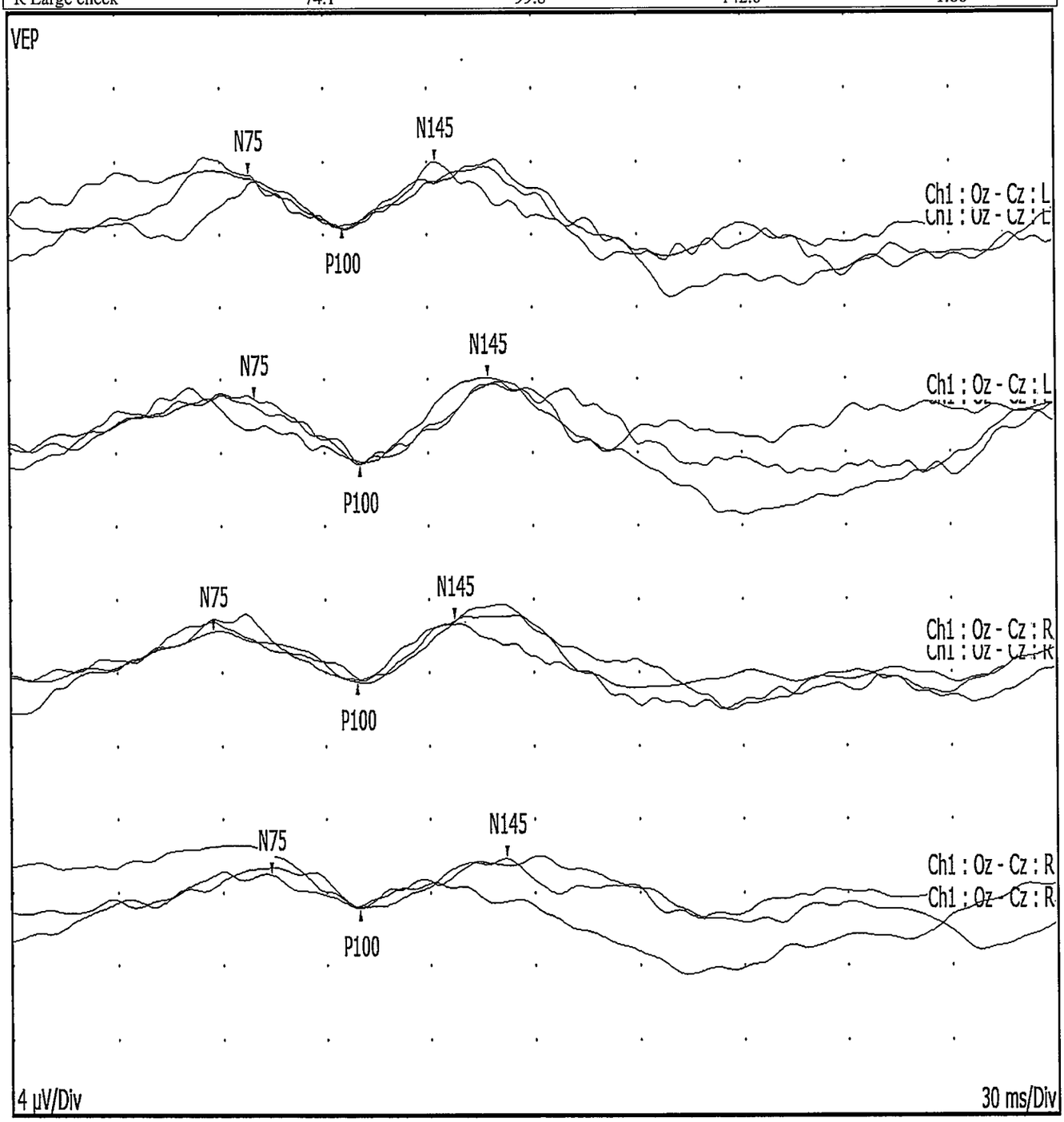

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL
원본대조필

**Test Date:** 2025-04-02

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Patient:** | 은비 박 | **DOB:** | 1995-02-09 | **Physician:** | 권영남 |
| **Sex:** | Female | **Height:** | 165 cm | **Ref Phys:** | |
| **ID#:** | 11255003 | **Weight:** | 70 kg | **Technician:** | 조인호 |

**VEP**

| Trace | N75 (ms) | P100 (ms) | N145 (ms) | N75-P100 (µV) |
|---|---|---|---|---|
| Norm | | <107.9 | | |
| L Small check | 68.4 | 95.6 | 122.3 | 2.81 |
| L Large check | 69.8 | 100.3 | 137.3 | 3.57 |
| R Small check | 57.7 | 99.4 | 127.5 | 2.80 |
| R Large check | 74.1 | 99.8 | 142.0 | 1.86 |

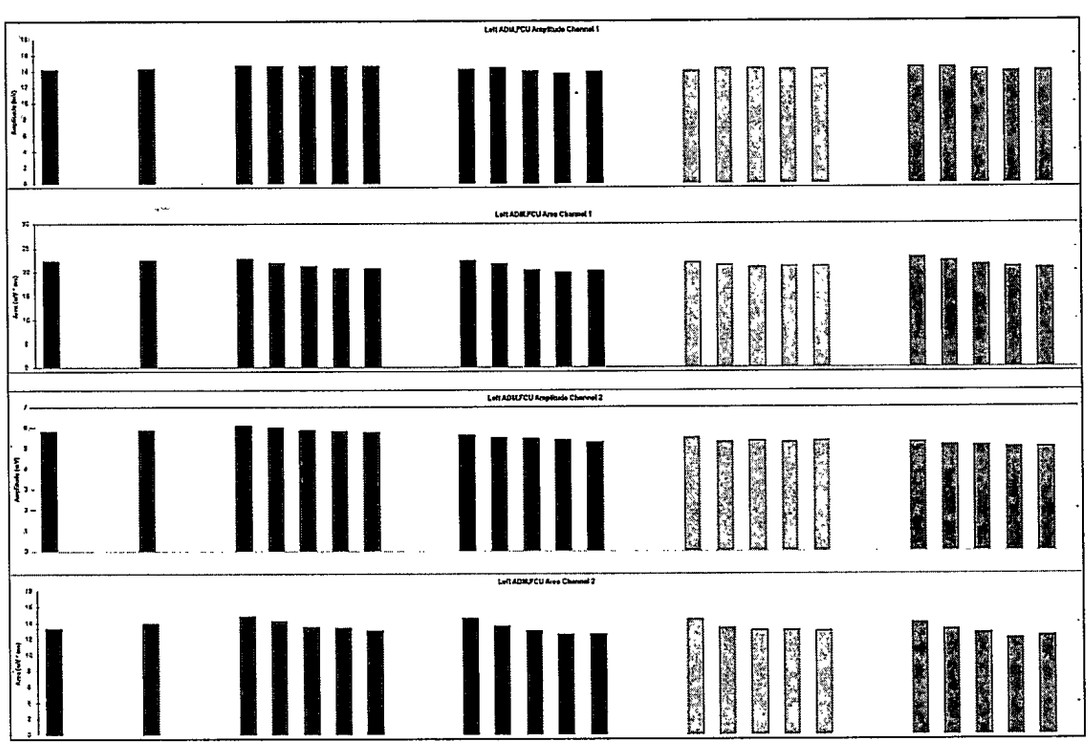


**Test Date:** 2025-04-02

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Patient:** | 은비 박 | **DOB:** | 1995-02-09 | **Physician:** | 권영남 |
| **Sex:** | Female | **Height:** | 165 cm | **Ref Phys:** | |
| **ID#:** | 11255003 | **Weight:** | 70 kg | **Technician:** | 조인호 |

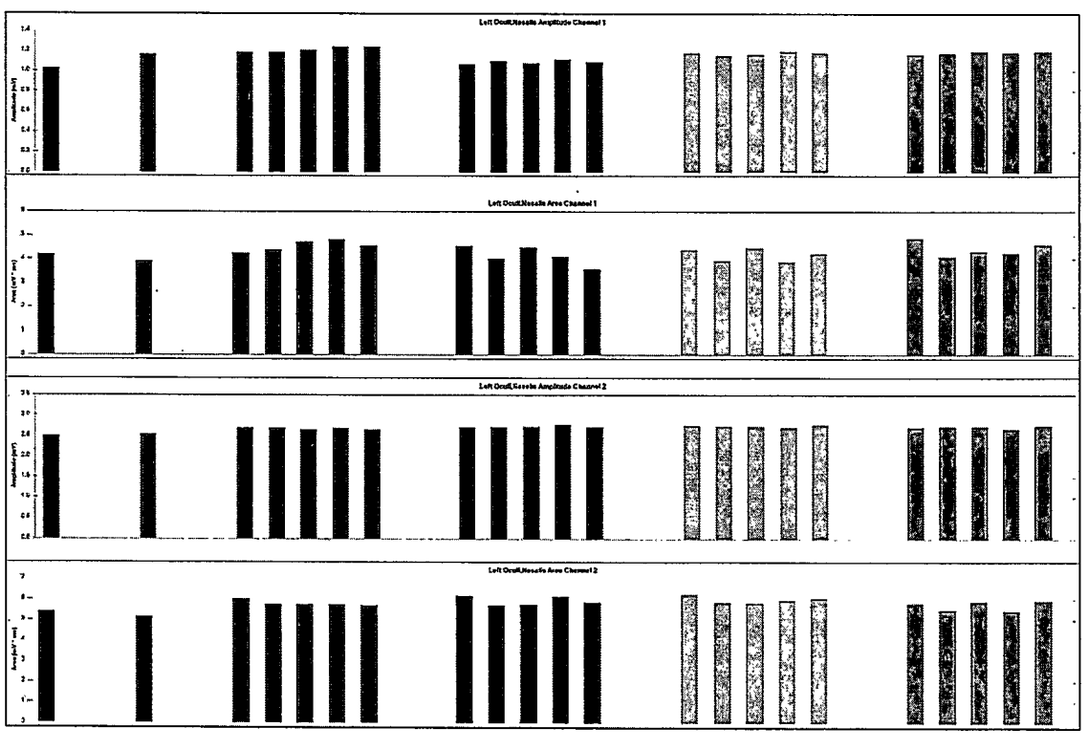
## RNS_Arm

| Trial # | Label | Amp 1 (mV) P-T | Amp 5 (mV) P-T | Amp % Dif | Area 1 (mV·ms) | Area 5 (mV·ms) | Area % Dif | Rep Rate | Train Length | Pause Time (min:sec) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Left ADM,FCU** | | | | | | | | | | | |
| Channel 1: Left ADM | | | | | | | | | | | |
| Tr 1 | Baseline | 14.26 | | | 22.38 | | | 1.00 | 1 | 00:30 | |
| Tr 2 | Post Excersise | 14.28 | | | 22.51 | | | 1.00 | 1 | 00:01 | |
| Tr 3 | 3Hz | 14.69 | 14.58 | -0.8 | 22.77 | 20.74 | -8.9 | 3.00 | 5 | 01:00 | |
| Tr 4 | 3Hz(1min) | 14.27 | 13.86 | -2.8 | 22.38 | 20.17 | -9.9 | 3.00 | 5 | 02:00 | |
| Tr 5 | 3Hz(3min) | 14.02 | 14.21 | 1.4 | 21.90 | 21.05 | -3.9 | 3.00 | 5 | 02:00 | |
| Tr 6 | 3Hz(5min) | 14.39 | 14.02 | -2.5 | 22.87 | 20.82 | -9.0 | 3.00 | 5 | 02:00 | |
| Channel 2: Left FCU | | | | | | | | | | | |
| Tr 1 | Baseline | 5.82 | | | 13.37 | | | 1.00 | 1 | 00:30 | |
| Tr 2 | Post Excersise | 5.87 | | | 13.89 | | | 1.00 | 1 | 00:01 | |
| Tr 3 | 3Hz | 6.08 | 5.78 | -5.0 | 14.81 | 13.06 | -11.8 | 3.00 | 5 | 01:00 | |
| Tr 4 | 3Hz(1min) | 5.64 | 5.28 | -6.4 | 14.59 | 12.57 | -13.8 | 3.00 | 5 | 02:00 | |
| Tr 5 | 3Hz(3min) | 5.50 | 5.33 | -3.1 | 14.48 | 12.97 | -10.4 | 3.00 | 5 | 02:00 | |
| Tr 6 | 3Hz(5min) | 5.25 | 5.02 | -4.4 | 14.06 | 12.36 | -12.1 | 3.00 | 5 | 02:00 | |



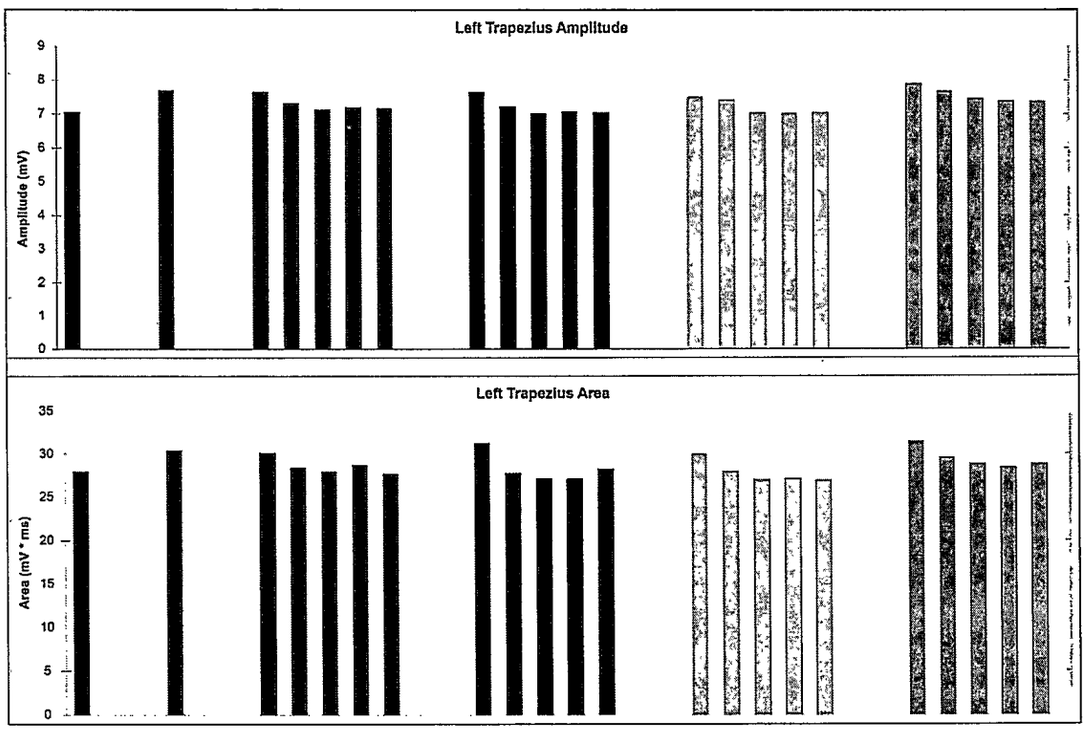
## RNS_Facial

| Trial # | Label | Amp 1 (mV) P-T | Amp 5 (mV) P-T | Amp % Dif | Area 1 (mV·ms) | Area 5 (mV·ms) | Area % Dif | Rep Rate | Train Length | Pause Time (min:sec) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Left Oculi,Nasalis** | | | | | | | | | | | |
| Channel 1: Left Oculi | | | | | | | | | | | |
| Tr 1 | Baseline | 1.03 | | | 4.18 | | | 1.00 | 1 | 00:30 | |
| Tr 2 | Post Excersise | 1.16 | | | 3.91 | | | 1.00 | 1 | 00:01 | |
| Tr 3 | 3Hz | 1.18 | 1.24 | 4.7 | 4.26 | 4.57 | 7.3 | 3.00 | 5 | 01:00 | |
| Tr 4 | 3Hz(1min) | 1.07 | 1.09 | 2.1 | 4.55 | 3.59 | -21.1 | 3.00 | 5 | 02:00 | |
| Tr 5 | 3Hz(3min) | 1.17 | 1.19 | 1.3 | 4.37 | 4.21 | -3.7 | 3.00 | 5 | 02:00 | |
| Tr 6 | 3Hz(5min) | 1.16 | 1.19 | 3.1 | 4.85 | 4.59 | -5.4 | 3.00 | 5 | 02:00 | |
| Channel 2: Left Nasalis | | | | | | | | | | | |
| Tr 1 | Baseline | 2.49 | | | 5.39 | | | 1.00 | 1 | 00:30 | |
| Tr 2 | Post Excersise | 2.54 | | | 5.13 | | | 1.00 | 1 | 00:01 | |
| Tr 3 | 3Hz | 2.70 | 2.65 | -2.0 | 6.01 | 5.70 | -5.1 | 3.00 | 5 | 01:00 | |
| Tr 4 | 3Hz(1min) | 2.71 | 2.71 | -0.2 | 6.14 | 5.85 | -4.9 | 3.00 | 5 | 02:00 | |
| Tr 5 | 3Hz(3min) | 2.74 | 2.77 | 1.1 | 6.22 | 6.03 | -3.0 | 3.00 | 5 | 02:00 | |
| Tr 6 | 3Hz(5min) | 2.71 | 2.74 | 1.1 | 5.78 | 5.93 | 2.5 | 3.00 | 5 | 02:00 | |

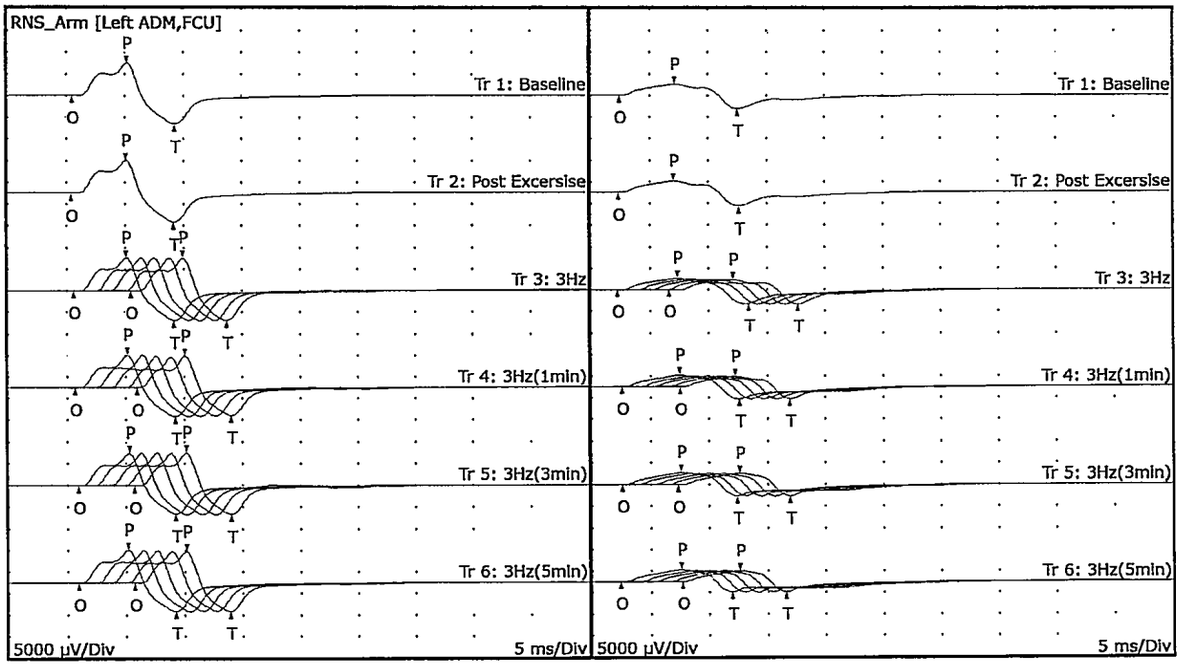


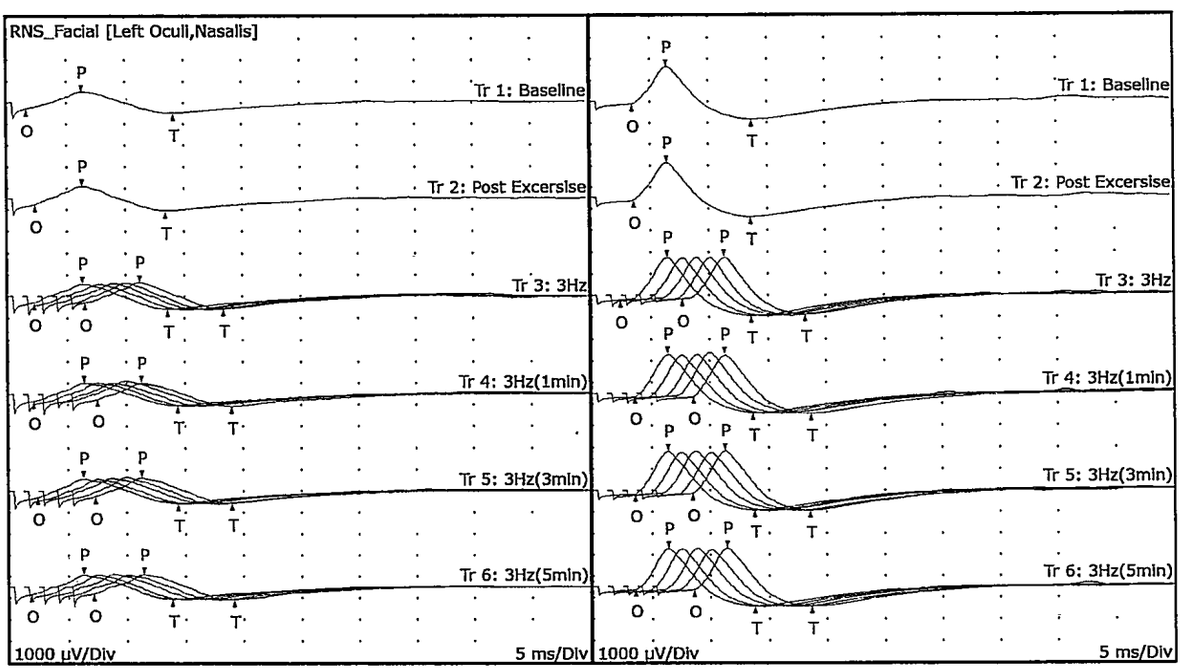
## RNS_Trapezius

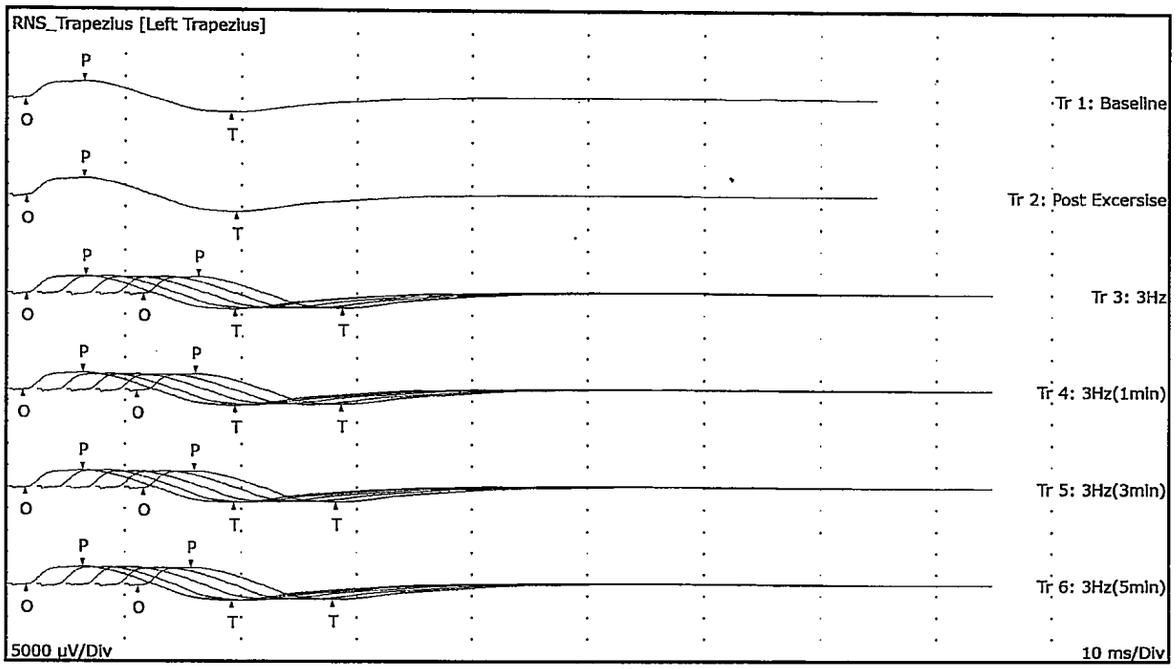
| Trial # | Label | Amp 1 (mV) P-T | Amp 5 (mV) P-T | Amp % Dif | Area 1 (mV·ms) | Area 5 (mV·ms) | Area % Dif | Rep Rate | Train Length | Pause Time (min:sec) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Left Trapezius** | | | | | | | | | | | |
| Tr 1 | Baseline | 7.06 | | | 27.97 | | | 1.00 | 1 | 00:30 | |
| Tr 2 | Post Excersise | 7.70 | | | 30.44 | | | 1.00 | 1 | 00:01 | |
| Tr 3 | 3Hz | 7.68 | 7.17 | -6.6 | 30.13 | 27.69 | -8.1 | 3.00 | 5 | 01:00 | |
| Tr 4 | 3Hz(1min) | 7.67 | 7.07 | -7.9 | 31.22 | 28.27 | -9.4 | 3.00 | 5 | 02:00 | |
| Tr 5 | 3Hz(3min) | 7.51 | 7.07 | -5.9 | 29.99 | 26.99 | -10.0 | 3.00 | 5 | 02:00 | |
| Tr 6 | 3Hz(5min) | 7.90 | 7.37 | -6.7 | 31.40 | 28.81 | -8.2 | 3.00 | 5 | 02:00 | |




## Waveforms:


RNS_Arm [Left ADM,FCU]
Tr 1: Baseline
Tr 2: Post Excersise
Tr 3: 3Hz
Tr 4: 3Hz(1min)
Tr 5: 3Hz(3min)
Tr 6: 3Hz(5min)
5000 µV/Div
5 ms/Div
5000 µV/Div
5 ms/Div


RNS_Facial [Left Oculi,Nasalis]
Tr 1: Baseline
Tr 2: Post Excersise
Tr 3: 3Hz
Tr 4: 3Hz(1min)
Tr 5: 3Hz(3min)
Tr 6: 3Hz(5min)
1000 µV/Div
5 ms/Div
1000 µV/Div
5 ms/Div


RNS_Trapezius [Left Trapezius]
Tr 1: Baseline
Tr 2: Post Excersise
Tr 3: 3Hz
Tr 4: 3Hz(1min)
Tr 5: 3Hz(3min)
Tr 6: 3Hz(5min)
5000 µV/Div
10 ms/Div

등록번호: 11255003
주민등록번호: 950209-219**** 여/30세
환자명: 박은비

# 근전도검사기록(2)

| | |
|---|---|
| 의뢰과 | 신경과 |
| 의뢰의 | 권영남 |
| 진찰결과 | 2024.11 두통, 어지럼,<br>주로 우측 측두부 에서 앞뒤로, 콕콕 찌르는 양상.<br>N/V -/-<br>duration: 2-3days?<br>freq: continual → 현재는 많이 호전됨.<br>편두통 약 복용하고 많이 호전됨: 테그레톨 에어탈 데파스 리보트릴<br><br>2025.2 부터 시각인지저하..? 사람얼굴이 흐릿하게 보인다.<br>글씨가 안읽힌다? 글씨를 읽으면 힘들다. 눈이 조여오는 것 같다.<br>촛점이 안맞는다?<br>두개로 보이지는 않는다? 겹쳐보이는것도 아니고<br><br>다리에 힘이 안들어가서 주저앉을뻔했다. 한번.<br>팔에 힘이 빠져나가는 느낌이 있다. 저림은 아니다.<br>머리감고 드라이하는데 문제없다.<br><br>글씨쓰기 수저질은 잘한다.<br><br>안과검사에서는 이상 없다고 들음. 좌안 시력저하만.<br>양안 다 어두워보인다. |
| 검사일 | 2025-04-02 |
| 검사결과 | 1. 시신경 유발전위검사<br>- Normal and symmetric latencies, shapes and amplitudes of P100 waves bilaterally.<br><br># P100 latencies (ms)<br>Left small check 95.6<br>Left large check 100.3<br>Right small check 99.4<br>Right large check 99.8<br><br>2. 반복신경자극검사<br>- No significant decremental responses to repetitive nerve stimulation on right abductor digiti minimi, flexor carpi ulnaris, orbicularis oculi, nasalis and trapezius muscles.<br><br>*RNST, repetitive nerve stimulation; ADM, abductor digiti minimi; FCU, flexor carpi ulnaris; NA, nasalis; OO, orbicularis oculi; TR, trapezius; QMG, quantitative myasthenia gravis weakness score |
| 결론 및 제언 | 시신경 유발전위검사상 conduction defects 소견은 관찰되지 않음.<br>반복신경자극검사상 neuromuscular junction transmission의 장애를 시사하는 소견은 관찰되지 않음. |
| 검사자 | 조인호 |
| 판독의 | 한희조 |


세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL
원본대조필

등록번호: 11255003
주민등록번호: 950209-219**** 여/30세
환자명: 박은비

# RNST report

진료과 신경과
주치의 권영남
등록번호 11255003 환자명 박은비 검사일 2025-04-02

RNST ☐ Right ☑ Left

| RNST (left side) | FCU | ADQ | OO | NA | TR |
|---|---|---|---|---|---|
| Baseline CMAP (uV) | 5820 | 14260 | 1030 | 2490 | 7060 |
| Post exercise CMAP* (uV) | 5870 | 14280 | 1160 | 2540 | 7700 |
| 3 pulse/sec (0min) : % | -5 | -0.8 | 4.7 | -2 | -6.6 |
| 3 pulse/sec (1min) : %** | -6.4 | -2.8 | 2.1 | -0.2 | -7.9 |
| 3 pulse/sec (3min) : % | -3.1 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | -5.9 |
| 3 pulse/sec (5min) : % | -4.4 | -2.5 | 3.1 | 1.1 | -6.7 |
| 50 pulse/sec : % | | | | | |

* CMAP amplitude after maximal voluntary contraction for 30 seconds
** Percent change of CMAP amplitude; - means decrement and + means increment
FCU: Flexor carpi ulnaris muscle ADQ:Abductor digiti quinti muscle TR: Trapezius muscle
OO:Orbicularis oculi muscle NA: Nasalis muscle

| 50PPS에서의 진폭변화 | FCU | ADQ |
|---|---|---|
| 1st CMAP amplitude (uV) | | |
| 5th CMAP amplitude (uV) | | |
| 10th CMAP amplitude (uV) | | |
| 20th CMAP amplitude (uV) | | |
| 30th CMAP amplitude (uV) | | |
| 50th CMAP amplitude (uV) | | |

**Stigmin Test ;**
Post-stigmin QMG
Result ;

Icepack test ;

기록자명 한희조


세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL
원본대조필

# 진 료 의 뢰 서

11255003
박은비
생년월일:1995.02.09
입력일자:2025.03.14
세브란스병원 입력완료

차트번호 : 8668
연 번 호 : 7-2025-53

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 보험자기관기호 | | 보험자기관명칭 | | 증번호 | 81374386030 |
| 피보험자 성명 | 박은비 | 주민등록번호 | | | |
| 수진자 성명 | 박은비 | 주민등록번호 | 950209-2192629 | | |
| 수진자 주소 | (10357 ) 경기도 고양시 일산동구 산두로229번길 36-7 (정발산동) | | | | |
| 상병명 | 상세불명의 중추신경계통의 탈수초질환<br>두통<br>어지럼증 및 어지럼 | | | 한국질병 분류기호<br>G379<br>R51<br>R42 | |
| 진료기간 | 2025년 2월 3일 부터<br>2025년 2월 20일 까지 ( 3 일간) | | | 진료구분 | 외래 |
| 환자상태 및 진료소견 | 특이병력 없던 분으로 작년 11월부터 발생한 두통, 어지럼증, 시야초점 안 맞는 증상 주소로 본원 내원하였습니다.<br>두통은 오른쪽 관자놀이에서 머리앞쪽, 정수리까지 퍼지는 양상으로 찌르듯이 하루종일 아프다고 하였으며 blurred vision으로 일을 하기 힘들고 글자가 안 읽힌다고 하였습니다, 안과 2군데에서 검사하였으나 좌안의 다소 시력저하 외 특이 소견은 없다고 들었다 합니다.<br>두통에 대해서는 본원에서 GONB, LONB injection 및 CBZ, GBP 약제 복용하며 호전되는 양상 보였으나 최근 1달간 시야증상은 집중이 어렵고 사람얼굴 인식이 잘 안되는 정도로 유지 혹은 악화되는 상태에 있어 젊은 나이인점을 고려할 때 ON, MS, NMOSD 등의 감별이 필요할 것으로 생각되어 진료 의뢰드립니다.<br>직장에서 대인관계의 스트레스는 있어왔다고 하며 그만둘 예정에 있다고 합니다.<br>고진선처 바랍니다. 감사합니다.<br><br>본인은 병원에서 진료받은 진료정보가 의뢰의사에게 제공되는 것에 동의합니다.<br>본인 : 박은비 서명 | | | | |

발 행 일 2025년 2월 27일
의 사 성 명 양화빈 (양화빈 인)
면 허 번 호 제 135845 호
주소 및 명칭 경기도 고양시 덕양구 화신로260번길 57, 4층
전 화 번 호 031-814-7582 (FAX) 031-814-[illegible]
두앤통신경과의원

주 : 1. 이 진료의뢰서는 1차진료 후 2차진료를 받고자 하는 경우 1차 진료 담당의사로부터 요양 급여 기준에 따라 무상으로 교부됩니다.
2. 의사의 발급일로부터 7일(공휴일 제외) 이내에 사용하여야 합니다.
3. 환자상태 및 진료 소견란에는 현증, 검사, 투약 등 주요 진료 내용을 구체적으로 기재하기 바라며 여백 부족시에는 뒷면을 활용하기 바랍니다.

출 력 일 자 2025년 02월 27일

등록번호: 11255003
주민등록번호: 950209-219**** 여/30세
환자명: 박은비

# 외래재진기록

2025-04-18

진료과 신경과

주치의 권영남

경과

---

2024.11 두통, 어지럼,
주로 우측 측두부 에서 앞뒤로, 콕콕 찌르는 양상.
N/V -/-
duration: 2-3days?
freq: continual → 현재는 많이 호전됨.
편두통 약 복용하고 많이 호전됨: 테그레톨 에어탈 데파스 리보트릴

2025.2 부터 시각인지저하..? 사람얼굴이 흐릿하게 보인다.
글씨가 안읽힌다? 글씨를 읽으면 힘들다. 눈이 조여오는 것 같다.
촛점이 안맞는다?
두개로 보이지는 않는다? 겹쳐보이는것도 아니고

다리에 힘이 안들어가서 주저앉을뻔했다. 한번.
팔에 힘이 빠져나가는 느낌이 있다. 저림은 아니다.
머리감고 드라이하는데 문제없다.

글씨쓰기 수저질은 잘한다.

안과검사에서는 이상 없다고 들음. 좌안 시력저하만.
양안 다 어두워보인다.

---

brain MRI + orbit
VEP normal study
RNST normal study
AChR Ab < 0.01

---

A> Moyamoya disease

P> stroke team

진단명

| 구분 | 확진 | 진단명 |
|---|---|---|
| 주진단 | 확진 | Encephalopathy, unspecified |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

기록자명 권영남(의사)



세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

원본대조필

등록번호: 11255003
주민등록번호: 950209-219**** 여/30세
환자명: 박은비

# 외래초진기록

2025-04-24

진료과 신경과

주치의 허준녕

주호소 및

■Problems
Moyamoya disease
Rt PCA territory chronic infarction (25.03)
가족력없음

■Diagnosis
none

■Medications (본원약)

■History
2024.11 두통, 어지럼,
주로 우측 측두부 에서 앞뒤로, 콕콕 찌르는 양상.
N/V -/-
duration: 2-3days?
freq: continual → 현재는 많이 호전됨.
편두통 약 복용하고 많이 호전됨: 테그레톨 에어탈 데파스 리보트릴

2025.2 부터 시각인지저하..? 사람얼굴이 흐릿하게 보인다.
글씨가 안읽힌다? 글씨를 읽으면 힘들다. 눈이 조여오는 것 같다.
촛점이 안맞는다?
두개로 보이지는 않는다? 겹쳐보이는것도 아니고

다리에 힘이 안들어가서 주저앉을뻔했다. 한번.
팔에 힘이 빠져나가는 느낌이 있다. 저림은 아니다.
머리감고 드라이하는데 문제없다.

글씨쓰기 수저질은 잘한다.

---
■Studies
@MR 2503
1. Suggestive of Moyamoya disease.
2. Small tiny recent infarction at right internal borderzone.
3. Chronic infarction at right temporo-parieto-occipital lobe and right frontal WM.

■Lab
LDL-Cholesterol (Friedewald) 105

현재질병상태

**과거력**

| | | |
|---|---|---|
| 당뇨병 | ◉ No | ○ Yes |
| Pul.Tbc | ◉ No | ○ Yes |
| 고혈압 | ◉ No | ○ Yes |
| 간염 | ◉ No | ○ Yes |
| Drug Allergy | ◉ No | ○ Yes |

** Yes선택시 구체적인 항생제 계열도 선택해주세요.

☐ Penicillin ☐ Sulfonamide ☐ Cephalosporin

☐ Other

| | | |
|---|---|---|
| 알레르기 | ◉ No | ○ Yes |

과거력 (others)

신체검진 (others)

**신체검진**

| | | |
|---|---|---|
| General appearance | ◉ normal | ○ abnormal |
| Skin | ◉ normal | ○ abnormal |
| HEENT | ◉ normal | ○ abnormal |
| Neck | ◉ normal | ○ abnormal |
| Chest/lung | ◉ normal | ○ abnormal |
| Heart | ◉ normal | ○ abnormal |
| Abdomen | ◉ normal | ○ abnormal |
| Back and extremity | ◉ normal | ○ abnormal |

추정진단

계획

DSA
start cilostazol
statin
mucosta

TCD/MES

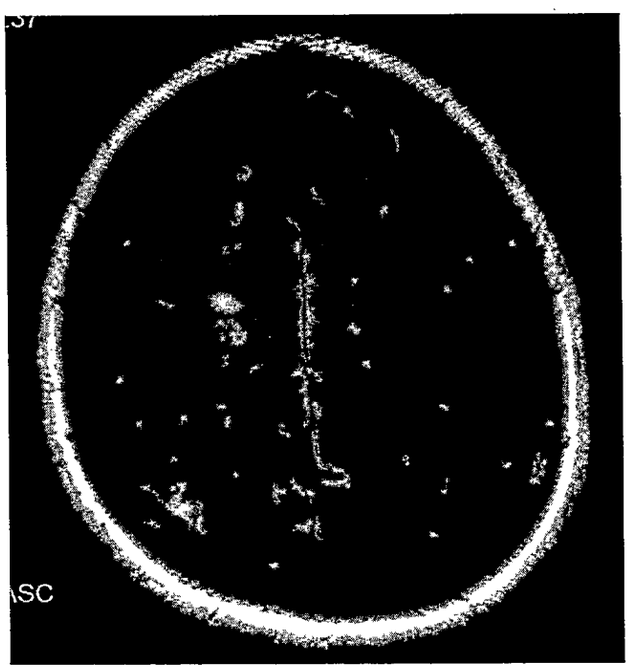
bypass관련 수술상담함.
if recur after medication → bypass candidate

RNF213

perfusion study 입원해서 할지 고민필요**

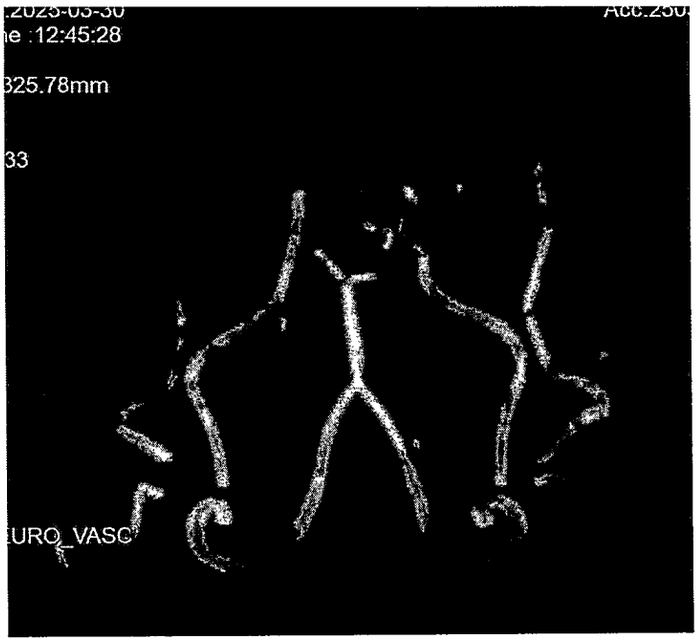
# 외래초진기록

2025-04-24



# 외래초진기록

2025-04-24




기록자명 허준녕(의사)

등록번호: 11255003
주민등록번호: 950209-219**** 여/30세
환자명: 박은비

# 퇴원요약

**입원정보**

입원일자 2025-05-01

입원과 신경과 입원주치의 허준녕

**퇴원정보**

퇴원일자 2025-05-03

퇴원과 신경과 퇴원주치의 허준녕

최종진단명(*)

| 순서 | 구분 | 확진 | 진단명 | 한국질병분류번호 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주진단 | 확진 | Moyamoya disease | I67.5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

과거진단명 Gastric erosion;

과거진단코드 K25.90;

주호소 (*) For: DSA



세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

원본대조필

과거력 및 현재병력

■Problems
Moyamoya disease
Rt PCA territory chronic infarction (25.03)
가족력없음

■Diagnosis
none

■Medications (본원약)

■History
2024.11 두통, 어지럼,
주로 우측 측두부 에서 앞뒤로, 콕콕 찌르는 양상.
N/V -/-
duration: 2-3days?
freq: continual → 현재는 많이 호전됨.
편두통 약 복용하고 많이 호전됨: 테그레톨 에어탈 데파스 리보트릴

2025.2 부터 시각인지저하..? 사람얼굴이 흐릿하게 보인다.
글씨가 안읽힌다? 글씨를 읽으면 힘들다. 눈이 조여오는 것 같다.
촛점이 안맞는다?
두개로 보이지는 않는다? 겹쳐보이는것도 아니고

다리에 힘이 안들어가서 주저앉을뻔했다. 한번.
팔에 힘이 빠져나가는 느낌이 있다. 저림은 아니다.
머리감고 드라이하는데 문제없다.

글씨쓰기 수저질은 잘한다.

---
■Studies
@MR 2503
1. Suggestive of Moyamoya disease.
2. Small tiny recent infarction at right internal borderzone.
3. Chronic infarction at right temporo-parieto-occipital lobe and right frontal WM.

■Lab
LDL-Cholesterol (Friedewald) 105

상기 여환 DSA 위해 입원함..

이상 진찰 소견 및 검사소견 (*)
No

투여된 약물 중 잔류효과로 퇴원 후 주의가 필요한 약물 (*) ◉ 없음 ○ 있음

경과요약 (*) DSA

수술/처치명 DSA

수술/처치코드

Implantable Medical Device 사용 여부 ◉ No ○ Yes

치료결과 (*) ◉ 완쾌 ○ 경쾌 ○ 호전안됨 ○ 진단뿐 ○ 가망없는 퇴원
○ 48시간이내 사망 ○ 48시간이후 사망

활력증상 혈압 120/80 mmHg 맥박수 70 회/분 체온 36.5 ℃ 호흡수 20 회/분

퇴원형태 (*) ◉ 퇴원지시후 ○ 타병원전원 ○ 자의퇴원 ○ 탈원

# 퇴원요약

| | |
|---|---|
| 향후 치료계획 | ◉ 외래 추후관리<br>○ 재입원<br>○ 없음<br>○ 기타 |
| 담당 전공의사명 | 이형우(의사) |
| 기록자명 | 이형우(의사) |
| 주치의사명 | 허준녕 |

등록번호: 11255003
주민등록번호: 950209-219**** 여/30세
환자명: 박은비

# 입원기록

입원일자 2025-05-01
입원과 신경과 입원주치의 허준녕

주호소 For: DSA

현재질병상태

■Problems

Moyamoya disease
Rt PCA territory chronic infarction (25.03)
가족력없음

■Diagnosis
none

■Medications (본원약)

■History
2024.11 두통, 어지럼,
주로 우측 측두부 에서 앞뒤로, 콕콕 찌르는 양상.
N/V -/-
duration: 2-3days?
freq: continual → 현재는 많이 호전됨.
편두통 약 복용하고 많이 호전됨: 테그레톨 에어탈 데파스 리보트릴

2025.2 부터 시각인지저하..? 사람얼굴이 흐릿하게 보인다.
글씨가 안읽힌다? 글씨를 읽으면 힘들다. 눈이 조여오는 것 같다.
촛점이 안맞는다?
두개로 보이지는 않는다? 겹쳐보이는것도 아니고

다리에 힘이 안들어가서 주저앉을뻔했다. 한번.
팔에 힘이 빠져나가는 느낌이 있다. 저림은 아니다.
머리감고 드라이하는데 문제없다.

글씨쓰기 수저질은 잘한다.

---
■Studies
@MR 2503
1. Suggestive of Moyamoya disease.
2. Small tiny recent infarction at right internal borderzone.
3. Chronic infarction at right temporo-parieto-occipital lobe and right frontal WM.

■Lab
LDL-Cholesterol (Friedewald) 105

상기 여환 DSA 위해 입원함..

**과거력**

| | | |
|---|---|---|
| Hypertension | ◉ No | ○ Yes |
| Pul. Tbc | ◉ No | ○ Yes |
| DM | ◉ No | ○ Yes |
| Hepatitis | ◉ No | ○ Yes |
| Smoking | ◉ No | ○ Yes |
| Alcohol | ◉ No | ○ Yes |

Allergy

| | |
|---|---|
| Drug | ◉ No |

○ Yes ☐ 항생제
☐ 진통제
☐ 조영제
☐ 기타

Food 및 기타 ◉ No
○ Yes

Cardiac disease ☑ No ☐ Yes
☐ MI ☐ stent ☐ CABG ☐ unstable angina
☐ Angiographically confirmed CAOD
☐ A.fib ☐ valvular heart disease ☐ Congestive heart failure
☐ others

CNS disorder ◉ No ○ Yes

Others

**신체조사**

| | | |
|---|---|---|
| General appearance | ◉ 이상소견 없음 | ○ 이상소견 있음 |
| Skin | ◉ 이상소견 없음 | ○ 이상소견 있음 |
| HEENT | ◉ 이상소견 없음 | ○ 이상소견 있음 |
| Neck | ◉ 이상소견 없음 | ○ 이상소견 있음 |
| Chest/lung | ◉ 이상소견 없음 | ○ 이상소견 있음 |
| Heart | ◉ 이상소견 없음 | ○ 이상소견 있음 |
| Abdomen | ◉ 이상소견 없음 | ○ 이상소견 있음 |
| Back and extremity | ◉ 이상소견 없음 | ○ 이상소견 있음 |

신경학적 검사 No

| Motor | | Rt | Lt |
|---|---|---|---|
| U/Ex | pro | | |
| | dis | | |
| L/Ex | pro | | |
| | dis | | |

others (Physical Exam)

**감염성질환 초기평가**

1. 증상 및 기간
   ☐ 발열 기간 일 전
   ☐ 호흡기증상 기간 일 전
   ☐ 소화기증상 기간 일 전
   ☑ 해당없음 (미상환자 포함)
2. 최근 1달 이내 방문한나라 ◉ 해당없음 ○ 없음 ○ 있음
3. 최근 1달 이내 국내 신종감염병 위험지역 또는병원 방문 ◉ 없음 ○ 있음
4. 밀접 접촉자 ◉ 해당없음 ○ 아니오 ○ 예

# 입원기록

5. 신종 감염병 의심환자 ◉ 아니오 ◯ 예

추정진단 Cerebral infarction

계획 DSA

**퇴원계획**

퇴원 후 치료식이 여부 ☑ N ☐ Y

추후 관리 계획 ☐ 가정간호사업소 ☐ 호스피스 ☐ 타 병원 전원 ☑ 외래

사회 복지서비스 연계 필요성 ☑ N ☐ Y

기타 퇴원시 요구사항

치료계획

| 구분 | Problem | Goal | 목표일 | 수정목표일 | 계획일 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

기록자명 이형우(의사)

<약어 설명>

BMI : body mass index

BP(D) : Blood Pressure(Diastolic)

BP(S) : Blood Pressure(Systolic)

BT : body temperature

C-sec : cesarean section

CVA : cerebrovascular accident

CVA tenderness : costovertebral angle

DM : diabetes mellitus

DOE : dyspnea on exertion

ECOG : eastern cooperative oncology group

HEENT : head, ear, eye, nose and throat

ICS : impulse conducting system(of the heart)

LMCL : left midclavicular line

LNs : lymph nodes

LOM : limitation of motion

NSVD : normal spontaneous vaginal delivery

PAOD : peripheral arterial occlusive disease

PMI : point of maximum impulse

PR : pulse rate

Pul. Tbc : pulmonary tuberculosis

RHB : regular heart beat

등록번호: 11255003
주민등록번호: 950209-219**** 여/30세
환자명: 박은비

# 경과기록

2025-05-02

| | |
|---|---|
| 진료과 | 신경과 |
| 주치의 | 허준녕 |
| 경과 | DSA for Moyamoya disease |
| 계획 | DSA without copmlication |

치료계획: 주치의가 환자의 치료계획을 확인함.

| | |
|---|---|
| 기록자명 | 허준녕(의사) |



세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

원본대조필

등록번호: 11255003
주민등록번호: 950209-219**** 여/30세
환자명: 박은비

# 경과기록

2025-05-03

퇴원 예정일 ◯ 유지 ◯ 변경

퇴원 후 치료식이 여부 ☑ N ☐ Y

추후 관리 계획 ☐ 가정간호사업소 ☐ 호스피스 ☐ 타 병원 전원 ☑ 외래

사회 복지서비스 연계 필요성 ☑ N ☐ Y

기타 퇴원시 요구사항

기록자명 허준녕



세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

원본대조필

등록번호: 11255003
주민등록번호: 950209-219**** 여/30세
환자명: 박은비

# 간호정보조사

2025-05-01

연령 구분 ○영유아기 ○학령전기 ○학령기 ○청소년기 ◉성인

분류 ◉일반 ○산모 ○정신

**현병력**

주·증상 및 내원 과정 2024.11 부터 두통, 어지러움.
2025.2 부터 시야장애, Weakness 발생함.
r/o MMD 로 DSA 위해 입원함.

**복용중인 약** ○없음 ◉있음

투약 상태

| 약품명 | 1회 투여개수 | | 1회 투여량 | | 횟수 | 용법 및 투여시간 | 약품 코드 | 유효함량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 수량 | 단위 | 용량 | 단위 | | | | |
| Lipitor [20 mg/T] | 1 | T | 20 | mg | 1 | PO | D2LIPI06 | 20 |
| Mucosta SR [150 mg/T] | 1 | T | 150 | mg | 2 | PO | D2MUCO10 | 150 |
| Pletaal SR [100 mg/C] | 1 | C | 100 | mg | 2 | PO | D2PLET02 | 100 |
| | | | | | | | | |

**내원 시 환자 상태**

통증 ○없음 ○있음 ◉입원 전에 있었음

통증 부위 ☐전신통 ☐흉통 ☐복통 ☐관절통 ☑두통 ☐요통 ☐상세부위

통증평가도구 NPIS(The Numerical Pain Intensity Scale) 통증 강도 2

통증 양상 ☐둔함 ☑쑤심 ☐퍼짐 ☐예리함 ☐찌르는듯함 ☐기타

빈도 ○지속적 ◉간헐적 간헐적 지속기간 간헐적

악화 요인 완화 요인 요즘은 진통제 복용할 정도 아니라 함

**과거력**

과거병력 ○없음 ◉있음

☐고혈압 ☐당뇨 ☐결핵 ☐암 ☐간염 ☐경련 ☑기타 Rt PCA territory chronic infarction (25.03)

입원 및 수술 이력 ◉없음 ○있음 ○알 수 없음

**가족력** ○없음 ◉있음

모 : 고혈압
이모: 고혈압 , 당뇨

음주력 ○nondrinker ○ex-drinker ◉current drinker

음주 횟수 한달에 1회 음주 시작 시기 20세

술의 종류 및 1회 음주량 맥주나 소주 1병

흡연력 ◉nonsmoker ○ex-smoker ○current smoker

**Allergy** ☑없음 ☐약 ☐식품

**일반정보(심적/사회적/경제적/영적/문화적/종교적 평가)**

**결혼 상태** ◉미혼 ○기혼 ○별거 ○이혼 ○사별 ○해당 없음

**종교** ○없음 ◉기독교 ○천주교 ○불교 ○기타

**원목 연락** ○원함 ◉원하지 않음

**보호자 (Main care giver)** ☐없음 ☐배우자 ☑부 ☑모 ☐자녀 ☐조부 ☐조모 ☐형제 ☐자매 ☐간병인 ☐기타

**입원비 지불의 어려움** ○있음 ◉없음 ○기타

**입원비 지불과 관련한 사회 사업팀 상담 필요** ○있음 ◉없음 ○기타

**지난 2주동안 기분이 가라앉거나, 우울하거나, 희망이 없다고 느낀 기간**

◉ 없음 ○ 2~3일 이상 ○ 7일 이상 ○ 거의 매일 ○ 확인 불가능

**지난 2주동안 평소 하던 일에 대한 흥미가 없어지거나 즐거움을 느끼지 못한 기간**

◉ 없음 ○ 2~3일 이상 ○ 7일 이상 ○ 거의 매일 ○ 확인불가능

**정서 평가** 0

*The Patient Health Questionnaire -2(PHQ-2) (2003).

**주 사용 언어** ☑ 한국어 ☐ 영어 ☐ 일본어 ☐ 중국어 ☐ 러시아어 ☐ 기타

**읽고 쓰는데 어려움** ◉ 없음 ○ 있음

**교육과 진료에 영향을 주는 가치와 신념(Value & belief)** ◉ 없음 ○ 있음

**퇴원**

**퇴원 후 보호자 (Main care giver)** ☐ 배우자 ☑ 부 ☑ 모 ☐ 자녀 ☐ 조부 ☐ 조모 ☐ 형제 ☐ 자매 ☐ 간병인 ☐ 기타 ☐ 없음

**퇴원 예정지** ◉ 자택 ○ 친척집 ○ 타병원 ○ 요양 시설 ○ 기타

**퇴원 예정 교통 수단(Discharge transportation)** ☐ 자가 ☑ 대중 교통 ☐ 항공 ☐ 구급차 ☐ 기타

**교육 요구도**

**교육 대상자** ☑ 환자 ☑ 보호자 ☐ 기타

**원하는 교육 내용** ☑ 질병 ☑ 약물 ☑ 검사 ☐ 수술 ☐ 자가 간호 ☐ 영양 ☐ 기타

**선호하는 교육 방법** ☑ 구두 ☑ 유인물 ☐ 시범 보이기 ☐ 시청각 자료

**영양 상태**

**1개월간 체중변화** ◉ 없음 ○ 증가함 ○ 감소함 체중변화 kg

**최근 1주일간 식사량 변화** ◉ 없음 ○ 증가 ○ 감소

**식이 주의 사항** ◉ 없음 ○ 열량 조절 ○ 체중 조절 ○ 염분 제한 ○ 수분 제한 ○ 단백질 제한 ○ 지방 제한 ○ 기타

**수면상태**

**수면장애** ◉ 없음 ○ 잠들기 어려움 ○ 수면 후 개운하지 않음 ○ 수면중 3회 이상 깸 ○ 원하는 시간보다 일찍 깸

**기능 평가**

**보조기 사용** ◉ 없음 ○ 목발 ○ 지팡이 ○ walker ○ 휠체어 ○ 기타

**기능 평가**

**일상생활 수행 능력** ◉ 독립적 수행 ○ 부분 보조 필요 ○ 완전 보조

**식사** ◉ 독립적 수행 가능 ○ 준비 시 도움받아 독립적 수행 가능 ○ 일부의 과정에서 도움이 필요함 ○ 모든 과정에서 도움이 필요함 ○ 전혀 수행할 수 없음

**개인 위생** ◉ 독립적 수행 가능 ○ 준비 시 도움받아 독립적 수행 가능 ○ 일부의 과정에서 도움이 필요함 ○ 모든 과정에서 도움이 필요함 ○ 전혀 수행할 수 없음

**목욕** ◉ 독립적 수행 가능 ○ 감독하에 독립적 수행 가능 ○ 일부의 과정에서 도움이 필요함 ○ 모든 과정에서 도움이 필요함 ○ 전혀 수행할 수 없음

**옷입기** ◉ 독립적 수행 가능 ○ 최소의 도움(단추, 지퍼 등)으로 독립적 수행 가능 ○ 도움을 받아 입고 벗을 수 있음 ○ 수행 시 약간의 참여가 가능함 ○ 전혀 수행할 수 없음

**화장실** ◉ 독립적 수행 가능 ○ 감독하에 독립적 수행 가능 ○ 일부의 과정에서 도움이 필요함 ○ 모든 과정에서 도움이 필요함 ○ 전혀 수행할 수 없음

**계단** ◉ 독립적 수행 가능 ○ 감독하에 독립적 수행 가능 ○ Walking aid 사용 없이 일부의 과정에서 도움이 필요함 ○ Walking aid 사용을 포함하여 모든 과정에서 도움이 필요함 ○ 전혀 수행할 수 없음

**걷기** ◉ 독립적 수행 가능 (휠체어를 제외한 walking aid 사용할 수 있음) ○ 도움이나 감시 없이는 50m 이상 혼자 걷지 못함 ○ 지속적인 Walking aid와 자주 다른 사람의 도움이 필요함 ○ 지속적으로 한사람 이상의 도움이 필요함

○ 전적으로 도움이 필요함

**이동 (의자와 침대)** ◉ 독립적 수행 가능 ○ 감독하에 독립적 수행 가능 ○ 이동시 일부의 과정에서 도움이 필요함 ○ 지속적으로 한 사람 이상의 도움이 필요함 ○ 전적인 도움이 필요함

**배변 조절** ◉ 조절에 문제 없음 ○ 조절이 잘 되나 가끔 문제가 발생함 ○ 자주 문제가 발생하며 기저귀의 도움이 필요함 ○ 자세를 취해주고 배변 시 도움이 필요함 ○ 변실금이 지속됨

**배뇨 조절** ◉ 조절에 문제 없음 ○ 가끔 문제가 발생 ○ 낮에는 조절 가능하나 밤에는 도움 필요 ○ 실금이 있으나 기구의 도움으로 해결 ○ 실금이 지속됨(유치 도뇨관)

**기능평가 점수 합계** 100

**신체사정**

**신경계**

시간 지남력 ◉ 있음 ○ 명확치 않음 ○ 없음
장소 지남력 ◉ 있음 ○ 명확치 않음 ○ 없음
사람 지남력 ◉ 있음 ○ 명확치 않음 ○ 없음
의사 소통 ◉ 원만함 ○ 어려움 ○ 불가능함

마비 ◉ 없음 ○ 있음 ○ 확인 불가능
Weakness ◉ 없음 ○ 있음 ○ 확인 불가능

**시각**

시각장애 ◉ 없음 ○ 있음

**청각**

청각장애 ◉ 없음 ○ 있음

**소화기계**

소화기 관련증상 ◉ 없음 ○ 있음

**순환기계**

Pacemaker ◉ 없음 ○ 있음
부종 ◉ 없음 ○ 있음
순환기 관련증상 ◉ 없음 ○ 있음

**호흡기계**

호흡기 관련증상 ◉ 없음 ○ 있음

**피부**

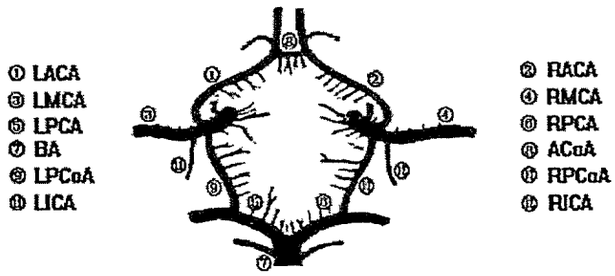
피부 온도 ◉ 따뜻함 ○ 뜨거움 ○ 차가움 피부 습도 ◉ 적당함 ○ 건조함 ○ 축축함
피부색 ◉ 이상없음 ○ 창백 ○ 홍조 ○ 청색증 ○ 황달
피부 변화 ◉ 없음 ○ 있음

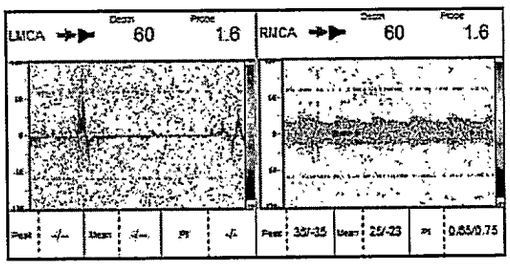
# 영상검사 특수촬영-Intervention

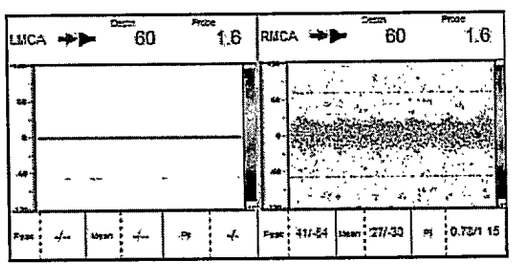
## 영상검사 특수촬영-Intervention

| | | | |
|---|---|---|---|
| 검사명 | [뇌신경]Cerebral Angiography** | | |
| 검사방법 | | | |
| 검사일자 | 2025.05.02 15:50 | 촬영실 | 혈관촬영 51호 |
| 판독일자 | 2025.05.07 10:04 | | |
| Description | Bilateral ICA, ECA, and VA angiograms were performed for evaluation of Moyamoya disease.<br><br>Under supine position, sterilization with alcohol at both inguinal areas and aseptic draping were done. After local anesthesia with 1% lidocaine, right femoral arterial puncture (Sono guided) was performed using Seldinger's method. 5F Sheath, 5F Headhunter angiocatheter, 035 Terumo guidewire were used.<br>Puncture site was sealed with Perclose device<br>The patient tolerated well without specific procedure-related complications.<br><br>Impression:<br>Pial collaterals were noted from bilateral PCAs to ipsilateral hemisphere.<br>Severe stenosis of left ICA and total occlusion of MCA and ACA.<br>Severe stenosis of left ICA and total occlusion of MCA and ACA with basal collaterals.<br>Transdural collaterals to both hemisphere were noted from the branches of ipsilateral ECAs.<br><br>Operators : 주하람/김동준<br>Assistants :<br>Written by : 주하람<br><br>◈조영제◈<br>Visipaque inj 320[100ml/Btl] [Iodixanol 652mg/ml(요오드로서 320mg/ml)] [100 ml/Btl]:1<br>Visipaque inj 320[50ml/Btl] [Iodixanol 652mg/ml(요오드로서 320mg/ml)] [50 ml/Btl]:2<br>Visipaque inj 320[50ml/Btl] [Iodixanol 652mg/ml(요오드로서 320mg/ml)] [50 ml/Btl]:1 | | |
| 판독의/전문의 | 김동준/김동준/김동준 | | |

**Name** PARK EUN BI **TCD ID** 11255003



Scan

# SEVERANCE HOSPITAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Name | PARK EUN BI | TCD ID | 11255003 |
| Gender | Female | Exam Date | 2025/05/02 |
| Age | 30Y | Exam Type | Monitoring Exam |
| D.O.B | 1995/02/09 | Disease Type | |

**TCD Exam Data:**

(In the report, the unit of Peak/Mean/Dias is cm/s(kHz), Depth's unit is mm, others have no unit)

| Vessel | Depth | Mean | PI | Peak | Dias | RI | Vessel | Depth | Mean | PI | Peak | Dias | RI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMCA | 60 | - | - | - | - | - | RMCA | 60 | 25 | 0.65 | 36 | 20 | 0.45 |
| LMCA | 60 | - | - | - | - | - | RMCA | 60 | 27 | 0.78 | 41 | 20 | 0.51 |

**TCD Conclusion:**

**Signature:**
**Report Date:** 2025/05/02

등록번호: 11255003
주민등록번호: 950209-219**** 여/30세
환자명: 박은비

# TCD MES monitoring

| | | | |
|---|---|---|---|
| 시행일자 | 2025-05-02 | 의뢰과 | 신경과 |
| | | 의뢰의 | 이형우 |

병력 및 의뢰사유 MMD

주요 진찰 소견

Monitoring duration 12 min

MES ○ Positive ◉ Negative

Number of MES counted 0

Findings

| | |
|---|---|
| 담당기사 | 서강식 |
| 판독의 | 김영대 |
| 확인자 | 김영대 |
| 보고일 | 2025-05-02 |

<약어 설명> TCD : transcranial doppler MES : microembolic signals



세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

원본대조필

등록번호: 11255003
주민등록번호: 950209-219**** 여/30세
환자명: 박은비

# TCD report

시행일자 2025-05-02 의뢰과 신경과
의뢰의 이형우

병력 및 의뢰사유 MMD
주요 진찰 소견

◯ Normal ◉ Abnormal ◯ Undetermined TCD study

**The temporal window**

temporal window was ◉ good ◯ poor
site ◉ bilateral side ◯ right side ◯ left side

**The Ophthalmic flow**

ophthalmic flow was ◉ normal direction ◯ reversed direction
site ◉ bilateral side ◯ left side ◯ right side

**The ACA flow**

ACA flow was ◉ normal direction ◯ reversed direction
site ◉ bilateral side ◯ left side ◯ right side

Findings

| Findings Right | MV | PI |
|---|---|---|
| Rt. MCA pro | 46 | 0.67 |
| Rt. MCA dis | 32 | 1.01 |
| Rt. ACA | -36 | 0.63 |
| Rt. PCA | -55 | 0.76 |
| Rt. Opth | 21 | 1 |
| Rt. Siph1 | 56 | 0.87 |
| Rt.VA | -33 | 0.82 |

| Findings Left | MV | PI |
|---|---|---|
| Lt. MCA pro | 128 | 0.54 |
| Lt. MCA dis | 21 | 0.82 |
| Lt. ACA | -91 | 0.49 |
| Lt. PCA | 38 | 0.81 |
| Lt. Opth | 23 | 0.81 |
| Lt. Siph1 | 38 | 1.01 |
| Lt. VA | -27 | 1.09 |
| BA pro | -45 | 0.82 |
| BA dis | -45 | 0.62 |

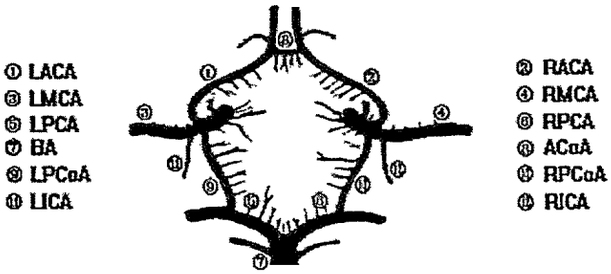
담당기사 서강식
판독의 김영대
확인자 김영대
보고일 2025-05-02

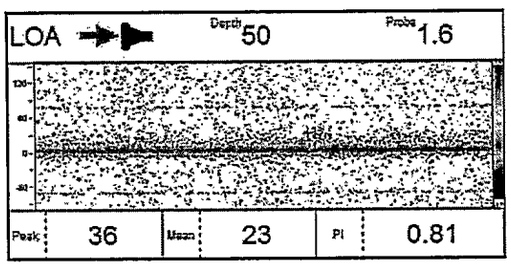

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL
원본대조필

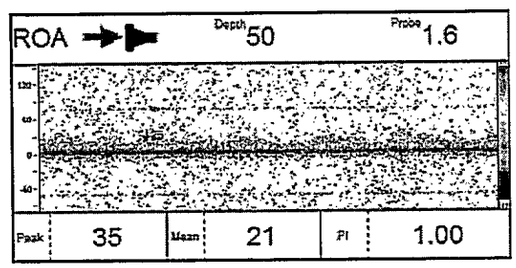
등록번호: 11255003
주민등록번호: 950209-219**** 여/30세
환자명: 박은비

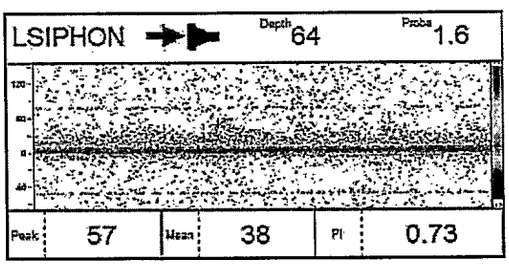
# TCD report

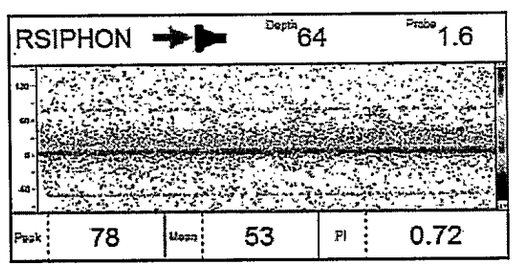
**Name** PARK EUN BI **TCD ID** 11255003

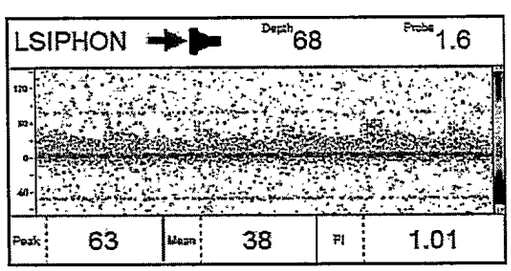


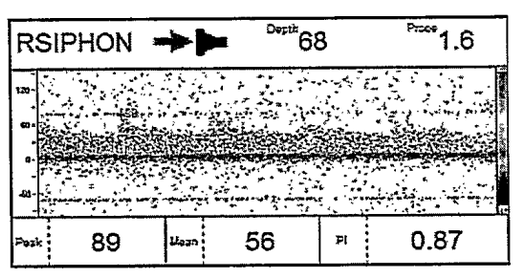



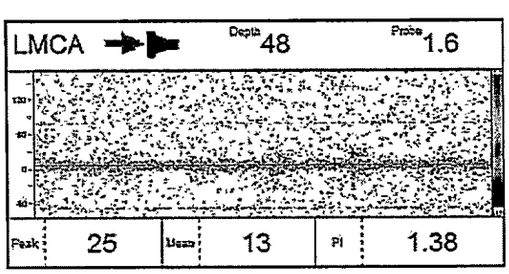



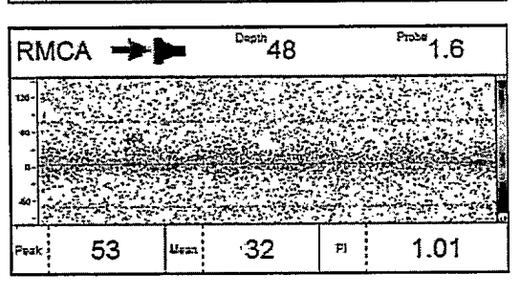



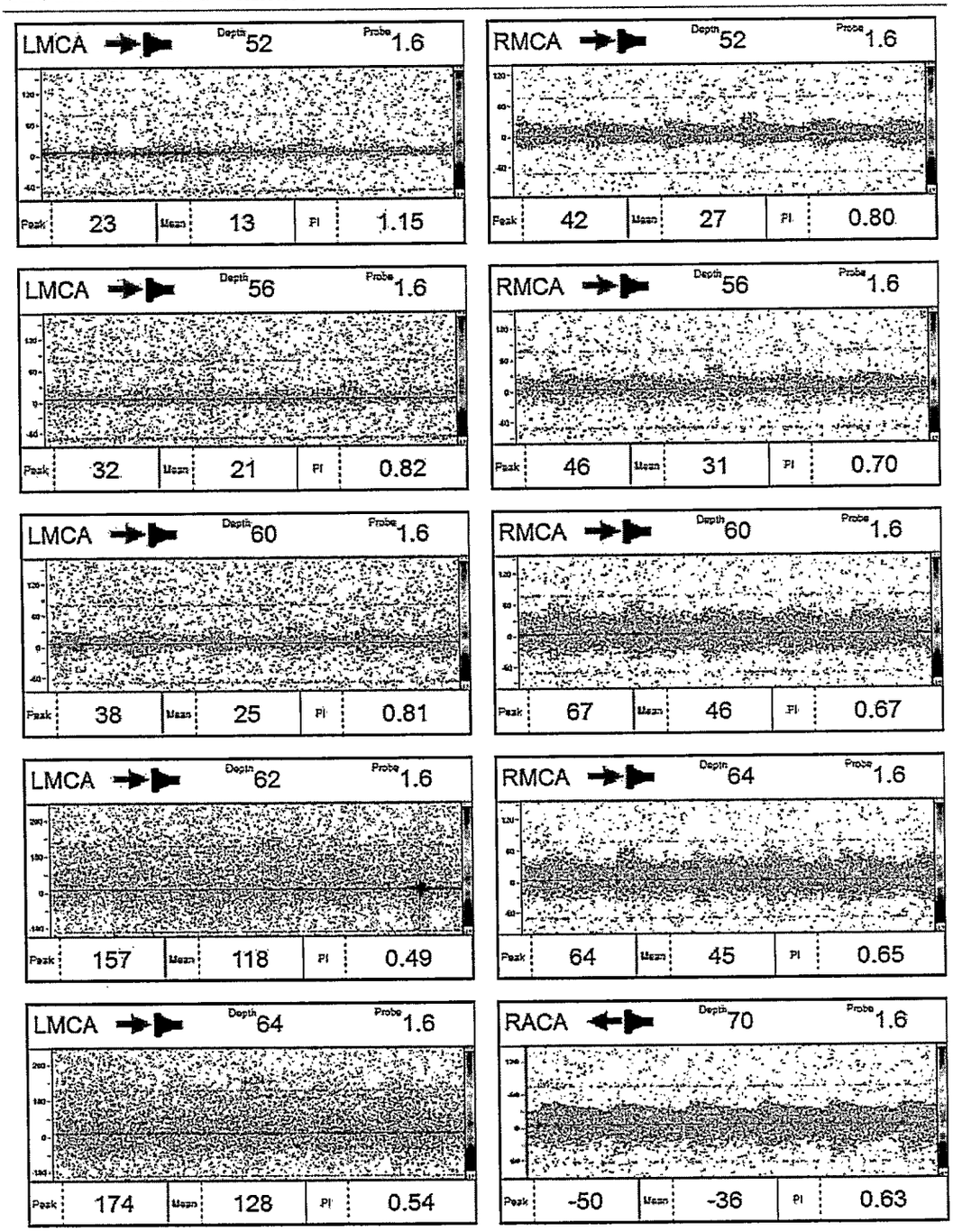



# TCD report

Name PARK EUN BI TCD ID 11255003

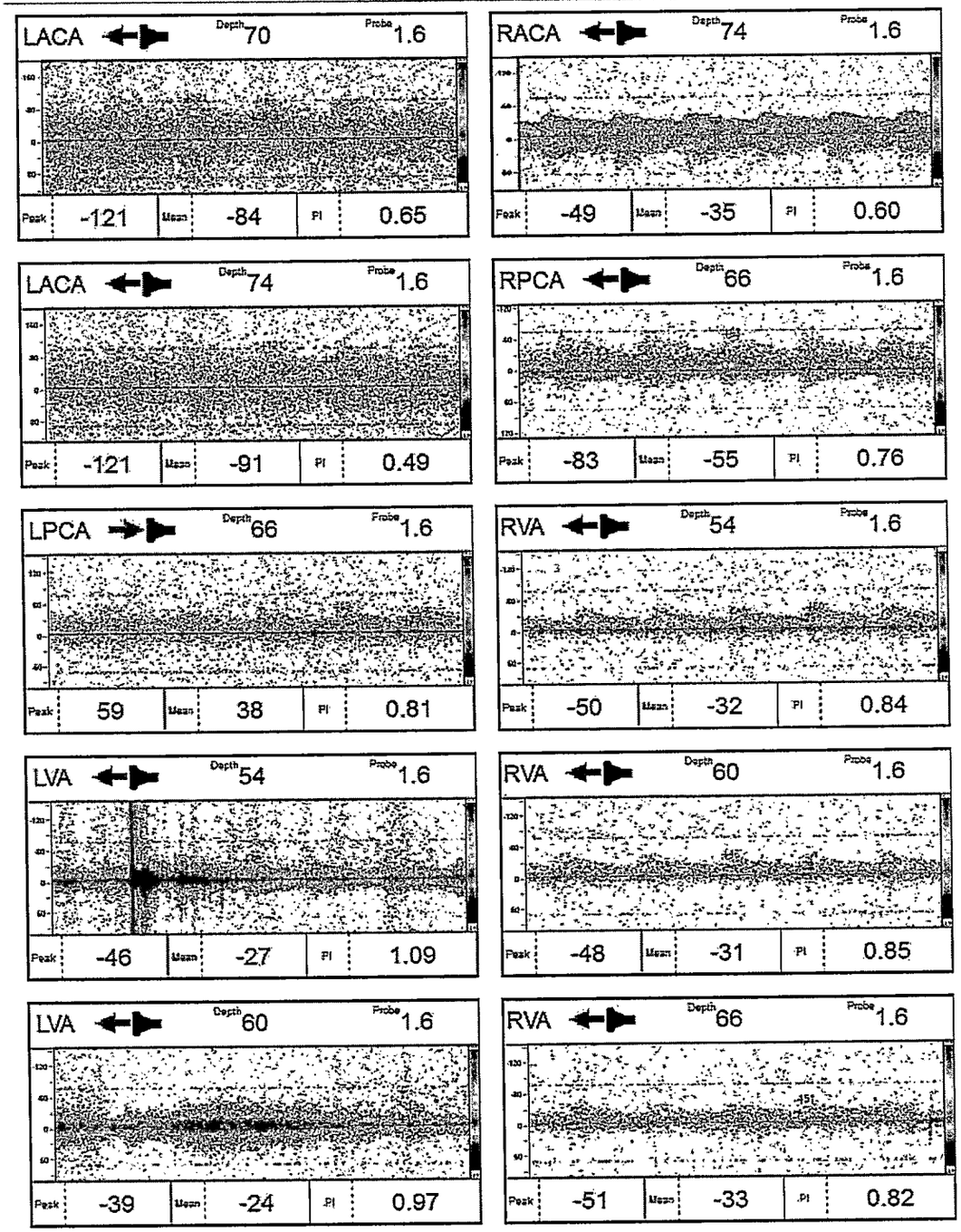



3/5

등록번호: 11255003
주민등록번호: 950209-219**** 여/30세
환자명: 박은비

# TCD report

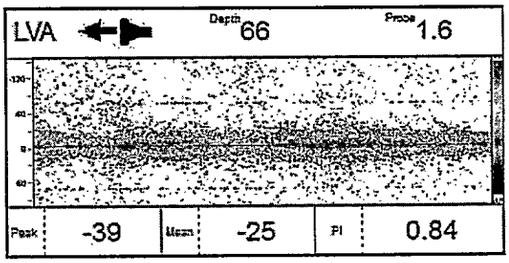
**Name** PARK EUN BI **TCD ID** 11255003

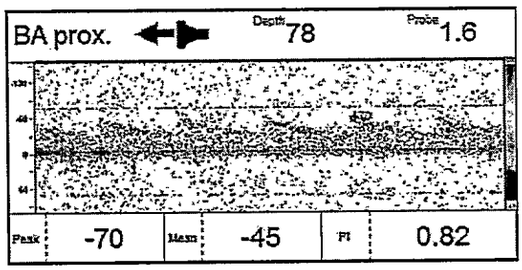


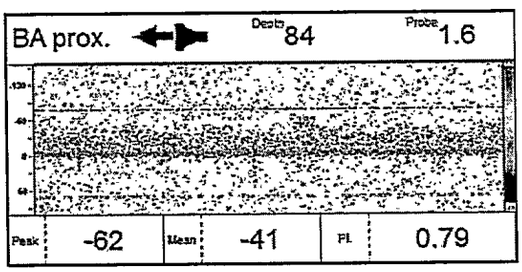

4/5

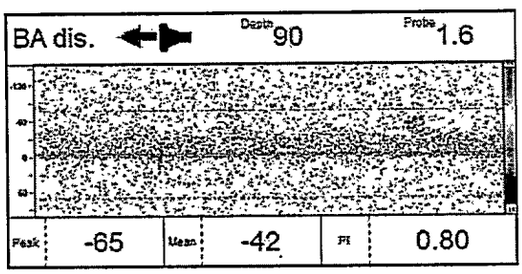
# TCD report

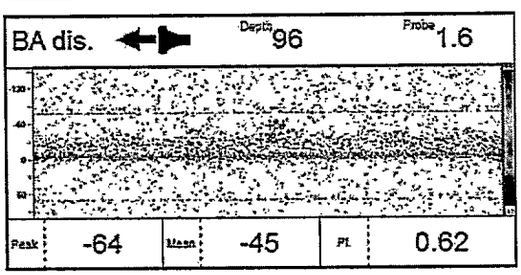
**Name** PARK EUN BI **TCD ID** 11255003




5/5

# TCD report

## SEVERANCE HOSPITAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Name | PARK EUN BI | TCD ID | 11255003 |
| Gender | Female | Exam Date | 2025/05/02 |
| Age | 30Y | Exam Type | Routine Exam |
| D.O.B | 1995/02/09 | Disease Type | |

**TCD Exam Data:**

(In the report, the unit of Peak/Mean/Dias is cm/s(kHz), Depth's unit is mm, others have no unit)

| Vessel | Depth | Mean | PI | Peak | Dias | RI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOA | 50 | 23 | 0.81 | 36 | 17 | 0.53 |
| LSIPHON | 64 | 38 | 0.73 | 57 | 29 | 0.49 |
| LSIPHON | 68 | 38 | 1.01 | 63 | 25 | 0.6 |
| LMCA | 48 | 13 | 1.38 | 25 | 7 | 0.72 |
| LMCA | 52 | 13 | 1.15 | 23 | 8 | 0.65 |
| LMCA | 56 | 21 | 0.82 | 32 | 15 | 0.53 |
| LMCA | 60 | 25 | 0.81 | 38 | 18 | 0.53 |
| LMCA | 62 | 118 | 0.49 | 157 | 99 | 0.37 |
| LMCA | 64 | 128 | 0.54 | 174 | 105 | 0.4 |
| LACA | 70 | -84 | 0.65 | -121 | -66 | 0.45 |
| LACA | 74 | -91 | 0.49 | -121 | -76 | 0.37 |
| LPCA | 66 | 38 | 0.81 | 59 | 28 | 0.53 |
| LVA | 54 | -27 | 1.09 | -46 | -17 | 0.63 |
| LVA | 60 | -24 | 0.97 | -39 | -16 | 0.59 |
| LVA | 66 | -25 | 0.84 | -39 | -18 | 0.54 |
| BA prox. | 78 | -45 | 0.82 | -70 | -33 | 0.53 |
| BA prox. | 84 | -41 | 0.79 | -62 | -30 | 0.52 |
| BA dis. | 90 | -42 | 0.8 | -65 | -31 | 0.52 |
| BA dis. | 96 | -45 | 0.62 | -64 | -36 | 0.44 |

| Vessel | Depth | Mean | PI | Peak | Dias | RI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 50 | 21 | 1 | 35 | 14 | 0.6 |
| RSIPHON | 64 | 53 | 0.72 | 78 | 40 | 0.49 |
| RSIPHON | 68 | 56 | 0.87 | 89 | 40 | 0.55 |
| RMCA | 48 | 32 | 1.01 | 53 | 21 | 0.6 |
| RMCA | 52 | 27 | 0.8 | 42 | 20 | 0.52 |
| RMCA | 56 | 31 | 0.7 | 46 | 24 | 0.48 |
| RMCA | 60 | 46 | 0.67 | 67 | 36 | 0.46 |
| RMCA | 64 | 45 | 0.65 | 64 | 35 | 0.45 |
| RACA | 70 | -36 | 0.63 | -50 | -28 | 0.44 |
| RACA | 74 | -35 | 0.6 | -49 | -28 | 0.43 |
| RPCA | 66 | -55 | 0.76 | -83 | -41 | 0.51 |
| RVA | 54 | -32 | 0.84 | -50 | -23 | 0.54 |
| RVA | 60 | -31 | 0.85 | -48 | -22 | 0.54 |
| RVA | 66 | -33 | 0.82 | -51 | -24 | 0.53 |

**TCD Conclusion:**

**Signature:**
**Report Date:** 2025/05/02

# 외래재진기록

2025-05-08

| | |
|---|---|
| 진료과 | 신경과 |
| 주치의 | 허준녕 |

Subjective

■Problems
Moyamoya disease
Rt PCA territory chronic infarction (25.03)
가족력없음

■Diagnosis
none

■Medications (본원약)

■History
2024.11 두통, 어지럼,
주로 우측 측두부 에서 앞뒤로, 콕콕 찌르는 양상.
N/V -/-
duration: 2-3days?
freq: continual → 현재는 많이 호전됨.
편두통 약 복용하고 많이 호전됨: 테그레톨 에어탈 데파스 리보트릴

2025.2 부터 시각인지저하..? 사람얼굴이 흐릿하게 보인다.
글씨가 안읽힌다? 글씨를 읽으면 힘들다. 눈이 조여오는 것 같다.
촛점이 안맞는다?
두개로 보이지는 않는다? 겹쳐보이는것도 아니고

다리에 힘이 안들어가서 주저앉을뻔했다. 한번.
팔에 힘이 빠져나가는 느낌이 있다. 저림은 아니다.
머리감고 드라이하는데 문제없다.

글씨쓰기 수저질은 잘한다.

---
25.04 DSA 이후 puncture site bleeding으로 타병원 응급실 내원 :
여기서보라고했음.

NO redness, no active bleeding. no hematoma
현재는 sabilize

# 외래재진기록

2025-05-08

Objective

■Studies
@MR 2503
1. Suggestive of Moyamoya disease.
2. Small tiny recent infarction at right internal borderzone.
3. Chronic infarction at right temporo-parieto-occipital lobe and right frontal WM.

@DSA 2504
bilateral ICA occlusion
Lt > Rt transdural collateral from ECA
pial collaetral both.

■Lab
LDL-cholesterol 51

LDL-Cholesterol (Friedewald) 105

RNf213 arg4810lys HETERO

Assessment MMD

Plan dressing 1wk f/u

Stroke 발생 ☐ Cerebral infarction ☐ Hemorrhage stroke ☐ Unknown stroke ☐ TIA

Stroke 발생 날짜

Stroke 발생 Comment

CAOD 발생 ☐ Acute MI ☐ Unstable angina ☐ PTCA/stent ☐ CABG ☐ Others

CAOD 발생 날짜

CAOD 발생 Comment

진단명

| 구분 | 확진 | 진단명 |
|---|---|---|
| 주진단 | 확진 | Cerebral infarction |
| 기타진단 | 확진 | Moyamoya disease |
| 기타진단 | 확진 | Gastric erosion |
| | | |
| | | |

기록자명 허준녕(의사)

등록번호: 11255003
주민등록번호: 950209-219**** 여/30세
환자명: 박은비

# 외래재진기록

2025-05-15

진료과 신경과

주치의 허준녕

Subjective

■Problems
Moyamoya disease
Rt PCA territory chronic infarction (25.03)
가족력없음

■Diagnosis
none

■Medications (본원약)

■History
2024.11 두통, 어지럼,
주로 우측 측두부 에서 앞뒤로, 콕콕 찌르는 양상.
N/V -/-
duration: 2-3days?
freq: continual → 현재는 많이 호전됨.
편두통 약 복용하고 많이 호전됨: 테그레톨 에어탈 데파스 리보트릴

2025.2 부터 시각인지저하..? 사람얼굴이 흐릿하게 보인다.
글씨가 안읽힌다? 글씨를 읽으면 힘들다. 눈이 조여오는 것 같다.
촛점이 안맞는다?
두개로 보이지는 않는다? 겹쳐보이는것도 아니고

다리에 힘이 안들어가서 주저앉을뻔했다. 한번.
팔에 힘이 빠져나가는 느낌이 있다. 저림은 아니다.
머리감고 드라이하는데 문제없다.

글씨쓰기 수저질은 잘한다.

---
25.04 DSA 이후 puncture site bleeding으로 타병원 응급실 내원 :
여기서보라고했음.

NO redness, no active bleeding. no hematoma
현재는 sabilize

---
25.05.15
다 나으셨음. 반창고도안해도됨.

# 외래재진기록

2025-05-15

Objective

■Studies
@MR 2503
1. Suggestive of Moyamoya disease.
2. Small tiny recent infarction at right internal borderzone.
3. Chronic infarction at right temporo-parieto-occipital lobe and right frontal WM.

@DSA 2504
bilateral ICA occlusion
Lt > Rt transdural collateral from ECA
pial collaetral both.

■Lab
LDL-cholesterol 51

LDL-Cholesterol (Friedewald) 105

RNf213 arg4810lys HETERO

Assessment MMD

Plan 약 repeat

Stroke 발생 ☐ Cerebral infarction ☐ Hemorrhage stroke ☐ Unknown stroke ☐ TIA

Stroke 발생 날짜

Stroke 발생 Comment

CAOD 발생 ☐ Acute MI ☐ Unstable angina ☐ PTCA/stent ☐ CABG ☐ Others

CAOD 발생 날짜

CAOD 발생 Comment

진단명

| 구분 | 확진 | 진단명 |
|---|---|---|
| 주진단 | 확진 | Cerebral infarction |
| 기타진단 | 확진 | Moyamoya disease |
| 기타진단 | 확진 | Gastric erosion |
| | | |
| | | |

기록자명 허준녕(의사)

등록번호 : 11255003
주민등록번호 : 950209-2****** / 30 세
성명 : 박은비

# 투약내역

기간 : 2025-01-18 ~ 2025-06-18

| 2025-04-24 (외래) | 2025-05-01 (입원) | 2025-05-02 (입원) | 2025-05-03 (입원) |
|---|---|---|---|
| 신경과 | 신경과 | 신경과 | 신경과 |
| Pletaal SR 100mg (2회/일) PO x14days | Muteran inj 600mg (2회/일) IVH x1days | Pletaal SR 100mg (2회/일) PO x1days | Pletaal SR 100mg (2회/일) PO x1days |
| Lipitor 20mg (1회/일) PO x14days | Pletaal SR 100mg (2회/일) PO x1days | Lipitor 20mg (1회/일) PO x1days | Lipitor 20mg (1회/일) PO x1days |
| Mucosta SR 150mg (2회/일) PO x14days | Lipitor 20mg (1회/일) PO x1days | Mucosta SR 150mg (2회/일) PO x1days | Mucosta SR 150mg (2회/일) PO x1days |
| | Mucosta SR 150mg (2회/일) PO x1days | | Pletaal SR 100mg (2회/일) PO x7days |
| | | | Mucosta SR 150mg (2회/일) PO x7days |
| | | | Lipitor 20mg (1회/일) PO x7days |

[원본대조필]



출력일 : 2025-06-18 출력자 : 박수진

관리파트/박*진/2025-06-18 15:19:14

등록번호 : 11255003
주민등록번호 : 950209-2****** / 30 세
성명 : 박은비

# 투약내역

기간 : 2025-01-18 ~ 2025-06-18

| 2025-05-08 (외래) | 2025-05-15 (외래) |
|---|---|
| 신경과 | 신경과 |
| Pletaal SR 100mg (2회/일) PO x7days | Pletaal SR 100mg (2회/일) PO x90days |
| Lipitor 20mg (1회/일) PO x7days | Lipitor 20mg (1회/일) PO x90days |
| Mucosta SR 150mg (2회/일) PO x7days | Mucosta SR 150mg (2회/일) PO x90days |
| | |
| | |
| | |

[원본대조필]

등록번호 : 11255003
주민등록번호 : 950209-219****  / 여
성명 : 박은비

# 의사지시기록

| 처방일 | 구분 | 처방내용1 | 처방내용2 | 종류 | 발생장소 | 처방자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-15 | P | Pletaal SR [100 mg/C] ▶ 1 C [100 mg] | (2회/일) 아침,저녁 식사 후 복용하십시오 [알약] x90days 1회 | 1회 | 뇌졸중센터 | 허준녕 |
| 2025-05-15 | P | Lipitor [20 mg/T] ▶ 1 T [20 mg] | (1회/일) 아침 식사 후 복용하십시오 [알약] x90days 1회 | 1회 | 뇌졸중센터 | 허준녕 |
| 2025-05-15 | P | Mucosta SR [150 mg/T] ▶ 1 T [150 mg] | (2회/일) 아침,저녁 식사 후 복용하십시오 [알약] x90days 1회 | 1회 | 뇌졸중센터 | 허준녕 |
| 2025-05-15 | L | CBC+PLT[Whole blood] | 1회 다음진료전 희망일 25-08-05 | 다음진료전,1회 | 뇌졸중센터 | 허준녕 |
| 2025-05-15 | L | WBC Differential Count[Whole blood] | 1회 다음진료전 희망일 25-08-05 | 다음진료전,1회 | 뇌졸중센터 | 허준녕 |
| 2025-05-15 | L | Routine Chemistry[Serum] | 1회 다음진료전 희망일 25-08-05 | 다음진료전,1회 | 뇌졸중센터 | 허준녕 |
| 2025-05-15 | L | Triglyceride[Serum] | 1회 다음진료전 희망일 25-08-05 | 다음진료전,1회 | 뇌졸중센터 | 허준녕 |
| 2025-05-15 | L | HDL-Cholesterol[Serum] | 1회 다음진료전 희망일 25-08-05 | 다음진료전,1회 | 뇌졸중센터 | 허준녕 |
| 2025-05-15 | L | LDL-cholesterol[Serum] | 1회 다음진료전 희망일 25-08-05 | 다음진료전,1회 | 뇌졸중센터 | 허준녕 |
| 2025-05-15 | L | Lipoprotein(a)[Serum] | 1회 다음진료전 희망일 25-08-05 | 다음진료전,1회 | 뇌졸중센터 | 허준녕 |
| 2025-05-15 | L | CK[Serum] | 1회 다음진료전 희망일 25-08-05 | 다음진료전,1회 | 뇌졸중센터 | 허준녕 |
| 2025-05-15 | G | 입퇴원증명서(진단명 포함) 1부 | 1회 | 1회 | 뇌졸중센터 | 허준녕 |
| 2025-05-08 | G | 일반진단서(보험용:1) 1부 | 1회 | 1회 | 뇌졸중센터 | 허준녕 |
| 2025-05-08 | P | Pletaal SR [100 mg/C] ▶ 1 C [100 mg] | (2회/일) 아침,저녁 식사 후 복용하십시오 [알약] x7days 1회 | 1회 | 뇌졸중센터 | 허준녕 |
| 2025-05-08 | P | Lipitor [20 mg/T] ▶ 1 T [20 mg] | (1회/일) 아침 식사 후 복용하십시오 [알약] x7days 1회 | 1회 | 뇌졸중센터 | 허준녕 |
| 2025-05-08 | P | Mucosta SR [150 mg/T] ▶ 1 T [150 mg] | (2회/일) 아침,저녁 식사 후 복용하십시오 [알약] x7days 1회 | 1회 | 뇌졸중센터 | 허준녕 |
| 2025-05-08 | T | Dressing (우측하지) x1 | (의사시행) 1회 | 1회 | 뇌졸중센터 | 허준녕 |
| 2025-05-03 | D | 일반식 밥[ 아침 : 본식 ] | Repeat 희망일 25-05-03 | Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-03 | D | 일반식 밥[ 점심 : 본식 ] | Repeat 희망일 25-05-03 | Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-03 | D | 일반식 밥[ 저녁 : 본식 ] | Repeat 희망일 25-05-03 | Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-03 | T | EKG monitoring x1 | Repeat | Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-03 | T | Pulseoximetry monitoring x1 | Repeat | Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-03 | T | Non Invasive BP monitoring x1 | Repeat | Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-03 | T | BP Check x6 | Repeat | Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-03 | T | PR Check x6 | Repeat | Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-03 | T | BT Check x3 | Repeat | Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-03 | T | RR Check x3 | Repeat | Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-03 | T | Neurologic examination(simple) x1 | (의사시행) Repeat | Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-03 | P | NS 이노엔 inj [1000 ml/Bag] ▶ 1 Bag [1000 ml] ◈40 ml/hr | (1회/일) 하루 한 번 IV infusion Repeat | Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-03 | P | Pletaal SR [100 mg/C] ▶ 1 C [100 mg] | (2회/일) 아침,저녁 식사 후 복용하십시오 [알약] Repeat | Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-03 | P | Lipitor [20 mg/T] ▶ 1 T [20 mg] | (1회/일) 아침 식사 후 복용하십시오 [알약] Repeat | Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-03 | P | Mucosta SR [150 mg/T] ▶ 1 T [150 mg] | (2회/일) 아침,저녁 식사 후 복용하십시오 [알약] Repeat | Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-03 | Z | ■ Pain Medication | Repeat | Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-03 | P | Tylenol-ER [650 mg/T] ▶ 2 T [1300 mg] | (2회/일) 아침,저녁 식사 후 복용하십시오 [알약] Repeat PRN PRN Daily 3일 제한 | PRN,Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-03 | P | Tridol inj [50 mg/A] ▶ 1 A [50 mg] | (2회/일) 12시간마다 근육주사 Repeat PRN PRN Daily 3일 제한 | PRN,Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-03 | Z | ■ Antipyretics | Repeat | Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |

**[원본대조필]**


출력일 : 2025-06-18
출력자 : 박수진

세브란스병원
YONSEI UNIVERSITY COLLEGE OF MEDICINE SEVERANCE HOSPITAL

등록번호 : 11255003
주민등록번호 : 950209-219****  / 여
성명 : 박은비

# 의사지시기록

| 처방일 | 구분 | 처방내용1 | 처방내용2 | 종류 | 발생장소 | 처방자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-03 | P | Diclon inj (IV 불가) [90 mg/A] ▶ 1 A [90 mg] | (1회/일) 하루 한 번 근육주사 Repeat PRN PRN Daily 3일 제한 | PRN,Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-03 | P | Profa infusion inj [1 g/Bag] ▶ 1 Bag [1 g] | (1회/일) 하루 한 번 IV infusion Repeat PRN PRN Daily 3일 제한 | PRN,Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-03 | P | Denogan inj [1000 mg/V] ▶ 1 V [1000 mg] ◈15 min | (1회/일) 하루 한 번 IV infusion Repeat PRN PRN Daily 3일 제한 | PRN,Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-03 | T | NPI (Neurologic assessment using NPI)(1일당) x1 | Repeat | Repeat | 뇌졸중 집중치 | 허준녕 |
| 2025-05-03 | P | Pletaal SR [100 mg/C] ▶ 1 C [100 mg] →eock eock | (2회/일) 아침,저녁 식사 후 복용하십시오 [알약] x7days 1회 퇴원약 | 퇴원약,1회 | 뇌졸중 집중치 | 허준녕 |
| 2025-05-03 | P | Mucosta SR [150 mg/T] ▶ 1 T [150 mg] →eock eock | (2회/일) 아침,저녁 식사 후 복용하십시오 [알약] x7days 1회 퇴원약 | 퇴원약,1회 | 뇌졸중 집중치 | 허준녕 |
| 2025-05-03 | P | Lipitor [20 mg/T] ▶ 1 T [20 mg] →eock | (1회/일) 아침 식사 후 복용하십시오 [알약] x7days 1회 퇴원약 | 퇴원약,1회 | 뇌졸중 집중치 | 허준녕 |
| 2025-05-03 | Z | 이전약 7일분 정도 남아 있으실거 같습니ㅏㄷ. | 1회 | 1회 | 뇌졸중 집중치 | 허준녕 |
| 2025-05-02 | D | 일반식밥[ 저녁 : 본식 ] | Repeat 희망일 25-05-02 | Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-02 | T | EKG monitoring x1 | Repeat | Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-02 | T | Pulseoximetry monitoring x1 | Repeat | Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-02 | T | Non Invasive BP monitoring x1 | Repeat | Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-02 | T | BP Check x6 | Repeat | Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-02 | T | PR Check x6 | Repeat | Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-02 | T | BT Check x3 | Repeat | Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-02 | T | RR Check x3 | Repeat | Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-02 | T | Neurologic examination(simple) x1 | (의사시행) Repeat | Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-02 | P | NS 이노엔 inj [1000 ml/Bag] ▶ 1 Bag [1000 ml] ◈40 ml/hr | (1회/일) 하루 한 번 IV infusion Repeat | Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-02 | T | [삭제]EKG monitoring x1 | Repeat | Repeat | 예정 | 이형우 |
| 2025-05-02 | T | [삭제]Pulseoximetry monitoring x1 | Repeat | Repeat | 예정 | 이형우 |
| 2025-05-02 | T | [삭제]Non Invasive BP monitoring x1 | Repeat | Repeat | 예정 | 이형우 |
| 2025-05-02 | T | [삭제]NPI (Neurologic assessment using NPI)(1일당) x1 | Repeat | Repeat | 예정 | 이형우 |
| 2025-05-02 | T | [삭제]BP Check x6 | Repeat | Repeat | 예정 | 이형우 |
| 2025-05-02 | T | [삭제]PR Check x6 | Repeat | Repeat | 예정 | 이형우 |
| 2025-05-02 | T | [삭제]BT Check x3 | Repeat | Repeat | 예정 | 이형우 |
| 2025-05-02 | T | [삭제]RR Check x3 | Repeat | Repeat | 예정 | 이형우 |
| 2025-05-02 | P | Pletaal SR [100 mg/C] ▶ 1 C [100 mg] | (2회/일) 아침,저녁 식사 후 복용하십시오 [알약] Repeat | Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-02 | P | Lipitor [20 mg/T] ▶ 1 T [20 mg] | (1회/일) 아침 식사 후 복용하십시오 [알약] Repeat | Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-02 | P | Mucosta SR [150 mg/T] ▶ 1 T [150 mg] | (2회/일) 아침,저녁 식사 후 복용하십시오 [알약] Repeat | Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-02 | Z | ■ Pain Medication | Repeat | Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-02 | P | Tylenol-ER [650 mg/T] ▶ 2 T [1300 mg] | (2회/일) 아침,저녁 식사 후 복용하십시오 [알약] Repeat PRN PRN Daily 3일 제한 | PRN,Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-02 | P | Tridol inj [50 mg/A] ▶ 1 A [50 mg] | (2회/일) 12시간마다 근육주사 Repeat PRN PRN Daily 3일 제한 | PRN,Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-02 | Z | ■ Antipyretics | Repeat | Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-02 | P | Diclon inj (IV 불가) [90 mg/A] ▶ 1 A [90 mg] | (1회/일) 하루 한 번 근육주사 Repeat PRN PRN Daily 3일 제한 | PRN,Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |

**[원본대조필]**

등록번호 : 11255003
주민등록번호 : 950209-219**** / 여
성명 : 박은비

# 의사지시기록

| 처방일 | 구분 | 처방내용1 | 처방내용2 | 종류 | 발생장소 | 처방자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-02 | P | Profa infusion inj [1 g/Bag] ▶ 1 Bag [1 g] | (1회/일) 하루 한 번 IV infusion Repeat PRN PRN Daily 3일 제한 | PRN,Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-02 | P | Denogan inj [1000 mg/V] ▶ 1 V [1000 mg] ◈15 min | (1회/일) 하루 한 번 IV infusion Repeat PRN PRN Daily 3일 제한 | PRN,Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-02 | T | NPI (Neurologic assessment using NPI)(1일당) x1 | Repeat | Repeat | 뇌졸중 집중치 | 허준녕 |
| 2025-05-02 | Z | [2025-05-04] 퇴원예정입니다. | 1회 | 1회 | 신경과 | 허준녕 |
| 2025-05-02 | Z | D/C [30] [2025-05-04] 퇴원예정입니다. | 1회 희망일 25-05-02 | 1회 | 뇌졸중 집중치 | 허준녕 |
| 2025-05-02 | Z | [2025-05-04] 퇴원예정입니다. | 1회 | 1회 | 신경과 | 허준녕 |
| 2025-05-02 | H | [퇴원] 예정일:2025-05-03 (정상퇴원 ) | 1회 희망일 25-05-03 | 1회 | 뇌졸중 집중치 | 허준녕 |
| 2025-05-02 | B | 진료예약 : NM-신경과 허준녕(S) 2025-05-16 금 11:30 | 1회 | 1회 | 뇌졸중 집중치 | 허준녕 |
| 2025-05-02 | P | NS 이노엔 inj [1000 ml/Bag] ▶ 1 Bag [1000 ml] ◈40 ml/hr | (1회/일) 하루 한 번 IV infusion 1회 | 1회 | 뇌졸중 집중치 | 하우석 |
| 2025-05-01 | L | CBC+PLT[Whole blood] | 자체채혈 1회 | 1회 | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | L | WBC Differential Count[Whole blood] | 자체채혈 1회 | 1회 | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | L | ESR(Infrared Ray,Spin)[Whole blood] | 자체채혈 1회 | 1회 | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | L | Prothrombin Time(PT)[Plasma] | 자체채혈 1회 | 1회 | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | L | aPTT[Plasma] | 자체채혈 1회 | 1회 | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | L | [삭제]Routine Chemistry[Serum] | 자체채혈 1회 | 1회 | 예정 | 이형우 |
| 2025-05-01 | L | [삭제]CRP (C-Reactive Protein)[Serum] | 자체채혈 1회 | 1회 | 예정 | 이형우 |
| 2025-05-01 | L | Urinalysis with Microscopy[Random Urine] | 자체채혈 1회 | 1회 | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | R | Portable EKG (routine)-세브란스 By 임상병리사 x1 | 1회 예약일25-05-01-14:47 | 1회 | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | R | Chest PA x1 | 1회 예약일25-05-01-15:02 | 1회 | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | D | [삭제]일반식 밥[ 아침 : 본식 ] | Repeat 희망일 25-05-02 | Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | D | [삭제]일반식 밥[ 점심 : 본식 ] | Repeat 희망일 25-05-02 | Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | D | 일반식 밥[ 저녁 : 본식 ] | Repeat 희망일 25-05-01 | Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | R | 혈관촬영: [뇌신경]Cerebral Angiography** →DSA #40486 x1 | 1회 예약일25-05-02-08:31 | 1회 | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | Z | <Pre- angio order> | 1회 | 1회 | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | Z | * get permission | 1회 | 1회 | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | Z | * inguinal shaving and betadine scrub | 1회 | 1회 | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | T | Shaving & cleansing x1 | 1회 | 1회 | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | T | Betadine scrub x1 | 1회 | 1회 | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | Z | * Maintain IV fluid on Lt. forearm | 1회 | 1회 | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | Z | *"조영제 : 당뇨병약 METFORMIN 투여환자인 경우 주사 48시간 전후로 MEFTORMIN제 투여는 병용금기 대상입니다. 대상 환자인 경우, 주사 48시간 전후 복용금지에 대한 설명이 필요합니다." | 1회 | 1회 | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | Z | <prep> | 1회 | 1회 | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | Z | * Sand bag (heavy) | 1회 | 1회 | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | Z | * prep. medication 누락되지 않도록 챙길 것!! | 1회 | 1회 | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | Z | * send the Pt. to DSA with chart | 1회 | 1회 | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | Z | * Stretch car (on call) | 1회 | 1회 | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | P | Heparin inj(고위험의약품) [25000 unit/V](처음 투여) ▶ 1 V [25000 unit] | (1회/일) 하루 한 번 IV side shooting 1회 Prep | Prep,1회 | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | Z | <Post- angio order> | 1회 | 1회 | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | Z | * Apply sandbag on puncture site | 1회 | 1회 | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |

**[원본대조필]**

등록번호 : 11255003
주민등록번호 : 950209-219**** / 여
성명 : 박은비

# 의사지시기록

| 처방일 | 구분 | 처방내용1 | 처방내용2 | 종류 | 발생장소 | 처방자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-01 | Z | * Watch puncture site for oozing & swelling | 1회 | 1회 | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | Z | * ABR for 24hours (Perclose인 경우 3시간, Hemcon인 경우 4시간) | 1회 | 1회 | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | Z | * Check V/S q 30min 2회 | 1회 | 1회 | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | Z | * Check V/S q 1hour until stabilization | 1회 | 1회 | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | P | NS 이노엔 inj [1000 ml/Bag] ▶ 1 Bag [1000 ml] ◈40 ml/hr | (1회/일) 하루 한 번 IV infusion Repeat | Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | Z | *14gtt pre hydration 42gtt post hydration if serum creatinine > 1.4, then half saline if serum creatinine =< 1.4, then normal saline | 1회 | 1회 | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | Z | * "IV hydration 42gtt (cardiac problem이 없다면) * cardiac problem이 있으면 notify 후 hydration결정" | 1회 | 1회 | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | Z | ### NS 40cc/hr는 입원날부터 시작해주세요 | 1회 | 1회 | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | P | Muteran inj [600 mg/A](처음 투여) ▶ 1 A [600 mg] | (2회/일) 12시간마다 IV side shooting 1회 | 1회 | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | Z | # angio 당일날 아침식사 나오게 해주세요. MN NPO 대상자 아니면 아침먹고 대기합니다. | 1회 | 1회 | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | P | NS 이노엔 inj [1000 ml/Bag] ▶ 1 Bag [1000 ml] ◈120 ml/hr post hydration | (2회/일) 12시간마다 IV infusion 1회 | 1회 | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | L | CBC+PLT[Whole blood] | 자체채혈 1회 희망일 25-05-03 05:00 | 1회 | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | L | WBC Differential Count[Whole blood] | 자체채혈 1회 희망일 25-05-03 05:00 | 1회 | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | L | Prothrombin Time(PT)[Plasma] | 자체채혈 1회 희망일 25-05-03 05:00 | 1회 | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | L | aPTT[Plasma] | 자체채혈 1회 희망일 25-05-03 05:00 | 1회 | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | L | Routine Chemistry[Serum] | 자체채혈 1회 희망일 25-05-03 05:00 | 1회 | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | L | Na[Serum] | 자체채혈 1회 희망일 25-05-03 05:00 | 1회 | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | L | K[Serum] | 자체채혈 1회 희망일 25-05-03 05:00 | 1회 | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | L | Cl[Serum] | 자체채혈 1회 희망일 25-05-03 05:00 | 1회 | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | L | Triglyceride[Serum] | 자체채혈 1회 희망일 25-05-03 05:00 | 1회 | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | L | HDL-Cholesterol[Serum] | 자체채혈 1회 희망일 25-05-03 05:00 | 1회 | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | L | LDL-cholesterol[Serum] | 자체채혈 1회 희망일 25-05-03 05:00 | 1회 | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | T | EKG monitoring x1 | Repeat | Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | T | Pulseoximetry monitoring x1 | Repeat | Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | T | Non Invasive BP monitoring x1 | Repeat | Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | T | Neurologic examination(general) x1 | (의사시행) 1회 | 1회 | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | T | NPI (Neurologic assessment using NPI)(1일당) x1 | Repeat | Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | T | BP Check x6 | Repeat | Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | T | PR Check x6 | Repeat | Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | T | BT Check x3 | Repeat | Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | T | RR Check x3 | Repeat | Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | C | 영상의학과 협진의뢰/신경계인터벤션실 | 1회 | 1회 | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | R | 신경과: TCD (뇌혈류 초음파검사) 비급여 x1 | 1회 예약일25-05-02-09:36 | 1회 | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |

**[원본대조필]**

등록번호 : 11255003
주민등록번호 : 950209-219****  / 여
성명 : 박은비

# 의사지시기록

| 처방일 | 구분 | 처방내용1 | 처방내용2 | 종류 | 발생장소 | 처방자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-01 | R | 신경과: TCD MES monitoring (뇌혈류 미세혈전색전증 초음파검사) x1 | 1회 예약일25-05-02-09:36 | 1회 | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | P | Pletaal SR [100 mg/C] ▶ 1 C [100 mg] →/대차 | (2회/일) 아침,저녁 식사 후 복용하십시오 [알약] Repeat | Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | P | Lipitor [20 mg/T] ▶ 1 T [20 mg] →/대차 | (1회/일) 아침 식사 후 복용하십시오 [알약] Repeat | Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | P | Mucosta SR [150 mg/T] ▶ 1 T [150 mg] →/대차 | (2회/일) 아침,저녁 식사 후 복용하십시오 [알약] Repeat | Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | Z | ■ Pain Medication | Repeat | Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | P | Tylenol-ER [650 mg/T](처음 투여) ▶ 2 T [1300 mg] | (2회/일) 아침,저녁 식사 후 복용하십시오 [알약] Repeat PRN | PRN,Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | P | Tridol inj [50 mg/A](처음 투여) ▶ 1 A [50 mg] | (2회/일) 12시간마다 근육주사 Repeat PRN | PRN,Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | Z | ■ Antipyretics | Repeat | Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | P | Diclon inj (IV 불가) [90 mg/A](처음 투여) ▶ 1 A [90 mg] | (1회/일) 하루 한 번 근육주사 Repeat PRN | PRN,Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | P | Profa infusion inj [1 g/Bag](처음 투여) ▶ 1 Bag [1 g] | (1회/일) 하루 한 번 IV infusion Repeat PRN | PRN,Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | P | Denogan inj [1000 mg/V](처음 투여) ▶ 1 V [1000 mg] ◈15 min | (1회/일) 하루 한 번 IV infusion Repeat PRN | PRN,Repeat | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | Z | TCD, MES, DSa 동의서 아침에 받을게요. | 1회 | 1회 | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | Z | 4/24일자로 영상 협진 있습니다. 5/2 출근후 5/1일자로 바꿀게요 | 1회 | 1회 | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | L | Routine Chemistry[Serum] | 자체채혈 1회 | 1회 | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | L | Na[Serum] | 자체채혈 1회 | 1회 | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | L | K[Serum] | 자체채혈 1회 | 1회 | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | L | Cl[Serum] | 자체채혈 1회 | 1회 | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | L | CRP (C-Reactive Protein)[Serum] | 자체채혈 1회 | 1회 | 뇌졸중 집중치 | 이형우 |
| 2025-05-01 | Z | 요청병동(실) : Stroke Unit[외래->입원] | 1회 희망일 25-05-01 | 1회 | 신경과 | 허준녕 |
| 2025-05-01 | Z | 요청병동(실) : Stroke Unit[외래->입원] | 1회 희망일 25-05-01 | 1회 | 신경과 | 허준녕 |
| 2025-05-01 | Z | [2025-05-04] 퇴원예정입니다. | 1회 | 1회 | 신경과 | 이형우 |
| 2025-05-01 | Z | [2025-05-04] 퇴원예정입니다. | 1회 | 1회 | 신경과 | 이형우 |
| 2025-04-24 | P | [삭제]Pletaal SR [100 mg/C] ▶ 1 C [100 mg] | (2회/일) 아침,저녁 식사 후 복용하십시오 [알약] x30days 1회 | 1회 | 뇌졸중센터 | 허준녕 |
| 2025-04-24 | P | [삭제]Lipitor [20 mg/T] ▶ 1 T [20 mg] | (1회/일) 아침 식사 후 복용하십시오 [알약] x30days 1회 | 1회 | 뇌졸중센터 | 허준녕 |
| 2025-04-24 | P | [삭제]Mucosta SR [150 mg/T] ▶ 1 T [150 mg] | (2회/일) 아침,저녁 식사 후 복용하십시오 [알약] x30days 1회 | 1회 | 뇌졸중센터 | 허준녕 |
| 2025-04-24 | L | RNF213 gene mutation test[Whole blood] | 1회 오늘 희망일 25-04-24 | 오늘,1회 | 뇌졸중센터 | 허준녕 |
| 2025-04-24 | P | [삭제]Pletaal SR [100 mg/C] ▶ 1 C [100 mg] | (2회/일) 아침,저녁 식사 후 복용하십시오 [알약] x35days 1회 | 1회 | 뇌졸중센터 | 허준녕 |
| 2025-04-24 | P | [삭제]Lipitor [20 mg/T] ▶ 1 T [20 mg] | (1회/일) 아침 식사 후 복용하십시오 [알약] x35days 1회 | 1회 | 뇌졸중센터 | 허준녕 |
| 2025-04-24 | P | [삭제]Mucosta SR [150 mg/T] ▶ 1 T [150 mg] | (2회/일) 아침,저녁 식사 후 복용하십시오 [알약] x35days 1회 | 1회 | 뇌졸중센터 | 허준녕 |
| 2025-04-24 | R | 신경과: TCD (뇌혈류 초음파검사) 비급여 x1 | 1회 | 1회 | 뇌졸중센터 | 허준녕 |
| 2025-04-24 | R | 신경과: TCD MES monitoring (뇌혈류 미세혈전색전증 초음파검사) x1 | 1회 | 1회 | 뇌졸중센터 | 허준녕 |
| 2025-04-24 | Z | 비급여 진료 항목 및 금액 설명함 처방명:TCD (뇌혈류 초음파검사) 금액:254,000 | 1회 | 1회 | 신경과 | 허준녕 |

**[원본대조필]**

등록번호 : 11255003
주민등록번호 : 950209-219****  / 여
성명 : 박은비

# 의사지시기록

| 처방일 | 구분 | 처방내용1 | 처방내용2 | 종류 | 발생장소 | 처방자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-24 | Z | 비급여 진료 항목 및 금액 설명함 처방명:TCD MES monitoring (뇌혈류 미세혈전색전증 초음파검사) 금액:185,000 | 1회 | 1회 | 신경과 | 허준녕 |
| 2025-04-24 | S | 입원결정:NM-신경과/허준녕희망일(20250505) (Cerebral infarction) | 1회 | 1회 | 신경과 | 허준녕 |
| 2025-04-24 | Z | 요청병동(실) : Stroke Unit | 1회 입실전 | 입실전,1회 | 신경과 | 허준녕 |
| 2025-04-24 | R | 혈관촬영: [뇌신경]Cerebral Angiography** →DSA #40486 x1 | 1회 | 1회 | 뇌졸중센터 | 이형우 |
| 2025-04-24 | P | Pletaal SR [100 mg/C] ▶ 1 C [100 mg] | (2회/일) 아침,저녁 식사 후 복용하십시오 [알약] x14days 1회 | 1회 | 뇌졸중센터 | 허준녕 |
| 2025-04-24 | P | Lipitor [20 mg/T] ▶ 1 T [20 mg] | (1회/일) 아침 식사 후 복용하십시오 [알약] x14days 1회 | 1회 | 뇌졸중센터 | 허준녕 |
| 2025-04-24 | P | Mucosta SR [150 mg/T] ▶ 1 T [150 mg] | (2회/일) 아침,저녁 식사 후 복용하십시오 [알약] x14days 1회 | 1회 | 뇌졸중센터 | 허준녕 |
| 2025-04-24 | Z | [ 입원결정처방변경 ]입원결정:NM-신경과/허준녕희망일(20250501) (Cerebral infarction) | 1회 | 1회 | 신경과 | 이형우 |
| 2025-04-24 | Z | 요청병동(실) : Stroke Unit | 1회 입실전 | 입실전,1회 | 신경과 | 이형우 |
| 2025-04-18 | C | 신경과 협진의뢰/뇌신경센터/허준녕 | 1회 | 1회 | 신경과 | 권영남 |
| 2025-04-18 | B | 진료예약 : NM-신경과 허준녕(S) 2025-04-24 목 15:20 | 1회 | 1회 | 뇌신경센터 | 권영남 |
| 2025-03-14 | R | MRI Brain & Angio 3D(Neck포함)/diffusion(contrast) →orbit MRI (T1 enhance, fat suppression) 추가 부탁드립니다. x1 | 1회 예약일25-03-30-13:30 | 1회 | 뇌신경센터 | 권영남 |
| 2025-03-14 | M | CT/MRI용_SB Band 5*7.6cm x1 →orbit MRI (T1 enhance, fat suppression) 추가 부탁드립니다. | 1회 원내 | 1회 | 뇌신경센터 | 권영남 |
| 2025-03-14 | M | Ex Extension Filter Line-250MM-EW-SC-425/EA-EX-CARE-한성메디칼(이충열) x1 →orbit MRI (T1 enhance, fat suppression) 추가 부탁드립니다. | 1회 원내 | 1회 | 뇌신경센터 | 권영남 |
| 2025-03-14 | M | Gadovist prefilled inj[15ml/Syringe] [ Gadobutrol 604.72mg/ml ] [15 ml/Syringe] x1Syringe →orbit MRI (T1 enhance, fat suppression) 추가 부탁드립니다. | 1회 원내 | 1회 | 뇌신경센터 | 권영남 |
| 2025-03-14 | L | Acetylcholine receptor binding Ab[Serum] | 1회 오늘 희망일 25-03-20 | 오늘,1회 | 뇌신경센터 | 권영남 |
| 2025-03-14 | L | Free T4[Serum] | 1회 오늘 희망일 25-03-20 | 오늘,1회 | 뇌신경센터 | 권영남 |
| 2025-03-14 | L | TSH[Serum] | 1회 오늘 희망일 25-03-20 | 오늘,1회 | 뇌신경센터 | 권영남 |
| 2025-03-14 | R | 신경과: RNST(전기생리학적검사 단독) x1 | 1회 다음진료전 예약일25-04-02-15:20 | 다음진료전,1회 | 뇌신경센터 | 권영남 |
| 2025-03-14 | R | 신경과: VEP(전기생리학적검사 단독) x1 | 1회 예약일25-04-02-16:20 | 1회 | 뇌신경센터 | 권영남 |
| 2025-03-14 | L | CBC+PLT[Whole blood] | 1회 오늘 희망일 25-03-20 | 오늘,1회 | 뇌신경센터 | 권영남 |
| 2025-03-14 | L | WBC Differential Count[Whole blood] | 1회 오늘 희망일 25-03-20 | 오늘,1회 | 뇌신경센터 | 권영남 |
| 2025-03-14 | L | Na[Serum] | 1회 오늘 희망일 25-03-20 | 오늘,1회 | 뇌신경센터 | 권영남 |
| 2025-03-14 | L | K[Serum] | 1회 오늘 희망일 25-03-20 | 오늘,1회 | 뇌신경센터 | 권영남 |
| 2025-03-14 | L | Cl[Serum] | 1회 오늘 희망일 25-03-20 | 오늘,1회 | 뇌신경센터 | 권영남 |
| 2025-03-14 | L | Routine Chemistry[Serum] | 1회 오늘 희망일 25-03-20 | 오늘,1회 | 뇌신경센터 | 권영남 |
| 2025-03-14 | L | LDL-cholesterol[Serum] | 1회 오늘 희망일 25-03-20 | 오늘,1회 | 뇌신경센터 | 권영남 |
| 2025-03-14 | L | HDL-Cholesterol[Serum] | 1회 오늘 희망일 25-03-20 | 오늘,1회 | 뇌신경센터 | 권영남 |
| 2025-03-14 | L | Triglyceride[Serum] | 1회 오늘 희망일 25-03-20 | 오늘,1회 | 뇌신경센터 | 권영남 |

**[원본대조필]**


출력일 : 2025-06-18
출력자 : 박수진

세브란스병원
YONSEI UNIVERSITY COLLEGE OF MEDICINE SEVERANCE HOSPITAL